

학술연구논문(Research Articles)

잠재전이모형을 활용한 코로나19 시기 고령자의
삶의 만족도 유형의 종단적 변화 및 영향 요인 검증*임예림¹ · 이나연² · 박성민¹ · 윤소진³ · 홍세희⁴¹고려대학교 교육학과 석사과정, ²고려대학교 교육학과 석사수료,³고려대학교 교육학과 박사수료, ⁴고려대학교 교육학과 교수Analyzing Longitudinal Changes and Influencing Factors of
Life Satisfaction Among Older Adults During COVID-19
Using Latent Transition AnalysisYerim Lim¹, Na Yeon Lee¹, Seongmin Park¹, Sojin Yoon², Sehee Hong³¹M.A. Student, Dept. of Education, Korea University²Ph.D. Student, Dept. of Education, Korea University³Professor, Dept. of Education, Korea University

국문요약 본 연구는 잠재전이분석을 활용하여 통해 코로나19 초기와 후기 고령자의 삶의 만족도 유형 분류 및 변화 양상을 파악하였다. 분석 결과, 코로나19 초기(1차 연도)와 후기(2차 연도)에서 삶의 만족도 잠재프로파일은 모두 3개로 분류되었으며, 그 특성이 두 시점에서 유사하여 공통적으로 삶의 만족도 고 집단, 중 집단, 저 집단으로 명명하였다. 분류의 영향요인으로서는 두 시점 모두 가구 총자산, 일상생활 도움 필요 정도, 우울 및 친목모임 참여 여부가 유의했으며, 잠재전이분석 결과, 친목모임 참여 여부만이 유의한 전이 영향요인으로 나타났다. 본 연구는 종단적 자료를 활용하여 코로나19 시기 노년층의 삶의 만족도 유형을 확인하였으며, 삶의 만족도 유형 변화에 대한 사회활동 참여의 영향력을 검증하여 노년층의 사회활동 참여를 위한 적극적 지원의 필요성을 도출하였다. 본 연구 결과를 바탕으로 고령자 삶의 질 제고를 위한 방안이 다각적 관점에서 고려되기를 기대한다.

주제어 고령자, 성공적 노화, 삶의 만족도, 고령화연구패널, 잠재전이모형

Abstract This study aimed to identify the subtypes of life satisfaction among older adults during the early and later stages of COVID-19 and examine each subtype's transition pattern. The results of latent profile analysis revealed three latent profiles of the life satisfaction(low, moderate, high) in both the early and later stages of COVID-19, and the characteristics of these profiles remained consistent over time. Household net financial assets, activities of daily living, depression and participation in social gatherings had a significant effect on classification at both stages. Latent transition analysis results indicated that participation in social gatherings was the sole significant factor influencing the transitions between latent profiles. This study examined the changes in life satisfaction among the elderly during COVID-19 using longitudinal data. Furthermore, by identifying the crucial impact of social activity on life satisfaction, the study highlighted the importance of proactive support to encourage social participation among the elderly.

Key words: Elderly, Successful Aging, Life Satisfaction, Latent Transition Analysis

* 본 논문은 '2024 고용패널조사 학술대회 논문 공모전'에서 수상한 논문을 수정·보완한 연구임

First Author: Yerim Lim, yoongm29@naver.com

Corresponding Author: Sehee Hong, seheehong@korea.ac.kr

투고일: 2024. 10. 12. 심사완료일: 2024. 11. 26. 게재확정일: 2024. 11. 28.

I. 서론

보건의료기술의 발달로 인해 기대 수명이 증가하고 동시에 출산율이 저하됨에 따라, 오늘날 인구의 고령화는 세계적인 추세가 되었다(김미숙 외, 2003; UN DESA, 2022; Wilmoth, Bas, Mukherjee, & Hanif, 2023). 고령자란 주로 연령이 만 65세 이상인 사람을 일컫는데(OECD, 2024), 한국의 경우 2000년에 고령자가 전체 인구의 7.2%를 차지하며 고령화 사회로 진입하였고 가장 최근에 조사된 2023년의 결과에 따르면 고령자가 전체의 18.4%를 차지하고 있다(통계청, 2023a; World Bank, 2021). 이러한 추세가 지속될 경우 향후 2050년에는 고령자가 전체 인구의 40%에 도달할 것으로 추정되며, 이는 전 세계 국가들을 통틀어서 가장 높은 수준이다(통계청, 2023a; OECD, 2023a; Wilmoth et al., 2023).

급속한 고령자 인구 비율의 증가는 여러 사회경제적 문제와 관련되어 있다. 예를 들어 경제활동인구의 감소와 연금 수혜 인구의 증가는 국가 사회보장제도의 지속 가능성에 대한 우려를 낳으며, 노화가 진행될수록 만성 질병에 걸릴 확률이 높아짐에 따라 의료 서비스의 수요가 급증하여 국가 재정에 영향을 미친다(김미숙 외, 2003). 이에 대응하여 Rowe와 Kahn은 일반적인 노화와 구분되는 ‘성공적 노화(Successful Aging)’ 개념을 제시하며, 고령화의 긍정적인 측면에 초점을 맞추어 해당 인구의 잠재력을 개발하고 문제를 해결해나갈 것을 제안하였다(Rowe & Kahn, 1997, 2015). 이들에 따르면 성공적 노화는 낮은 질병 발생률, 높은 신체적·정신적 기능, 적극적인 사회 참여의 3가지 요소로 구성되며, 이는 고령자 개인의 삶의 만족도를 높이는 것과 관련이 깊다(김경래, 황남희, 진화영, 유재연, 2020; Cho, Martin, & Poon, 2015). 이러한 관점에서 보았을 때, 성공적인 고령 사회를 만들어 나가기 위한 노력의 일환으로 고령자의 삶의 만족도 제고에 기여하는 요인들을 밝혀내는 것이 중요하다.

한편, 생애 주기에 걸쳐 U자형 곡선 개형을 보이며 중장년기 이후에는 삶의 만족도가 증가하는 서구 국가들에 반해(Blanchflower & Oswald, 2008; Frijters & Beaton, 2012), 한국의 경우 연령이 증가할수록 삶의 만족도가 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다(김성아, 정해식, 2019). 이에 대해 가능한 설명으로 한국 고령자의 빈곤율은 2021년 가처분소득 중위 50% 기준으로 37.7%이며(한국보건사회연구원, 2023) OECD 국가들과 비교했을 때 최고 수준에 달한다는 점(OECD, 2023b), 고령자 자신의 건강 상태를 주관적으로 평가했을 때 긍정적인 응답의 비율이 OECD 평균의 절반 수준에 그쳤다는 점(OECD, 2023a) 등을 제시할 수 있다. 이러한 사회적 지표들의 결과로 미루어 보았을 때, 한국에서 고령자의 삶의 만족도를 저해하는 요인을 파악하여 개선할 수 있도록 지속적인 실증 연구가 필요하다.

더불어, 2020년 3월 11일 세계보건기구(WHO)에 의해 세계적 유행(Pandemic)으로 선언된 COVID-19(이하 코로나19)의 발생은 고령자의 삶의 질에 지대한 영향을 미쳤다(WHO, 2020). 코로나19로 인해 세계적으로 증가해오던 기대 수명이 2020년에 급락하였고(UN DESA, 2022), 한국의 경우에도 2022년 기준 기대 수명이 전년도 대비 0.9년 감소하였다(통계청, 2023b). 또한, 코로나19 발생 전후로 삶의 질의 여러 구성 요소들을 비교한 결과, 삶의 만족도가 모든 연령대에서 감소하였다(여유진, 2022). 고령자의 경우 만성질환과 기능 상태 저하로 인해 코로나19 감염과 합병증 발생에 취약하며, 코로나19의 확산을 막기 위해 시행된 사회적 거리두기로 인해 가족을 포함한 지인들과의 만남이 제한됨에 따라 불안, 염려, 우울 등 부정적 정서를 경험한 노인이 많이 나타났다(남궁은하, 2021; 최혜진, 2023). 특히 고령자의 적극적인 사회 참여와 사회적 관계 유지는 성공적 노화를 위한 조건이며 고령자의 사회적 관계가 삶의 질에 주요한 영향을 미친다는 연구 결과들을 고려했을 때(박선숙, 2018; 석재은, 장은진, 2016), 코로나19로 인한 사회적 고립은 고령자의 부정적 정서를 강화해 신체적·정신적 문제를 야기하고 삶의 만족도를 저하시켰을 수 있다(배고은, 2022). 그러나 한편으로는 고령자 세대의 회복탄력성이나 국가 정책으로 인해 코로나19 시기 고령자의 삶의 만족도가 오히려 증가했다는 연구 결과도 존재한다(이서연, 장미나, 2022). 이처럼 코로나19 시기의 연구들이 다소 혼재된 결과를 보이는 것은, 연구에 활용된 자료의 상이한 조사 시점에 따른 결과일 수 있다. 코로나19 시기는 크게 소규모 및 중간규모 집단의 확진자가 주로 발생했던 제1기(2020.1~8)와 제2기(2020.8~11),

바이러스의 전국적 확산 및 백신 접종이 이루어진 제3기(2020.11~2021.7)와 제4기(2021.7~2022.1), 오미크론 및 신종 변이바이러스 확산 이후(2022.1), 사회적 거리두기 해제(2022.4) 및 국내 엔데믹 선언(2023.5) 등으로 구분해 볼 수 있으며(양성찬 외, 2022; 질병관리청, 2023; 하진호, 이지연, 최소영, 박숙경, 2023), 제시된 시점에 따라 개인의 삶의 만족도 및 관련 요인들의 수준이 상이하게 나타날 수 있다. 따라서, 종단적 자료를 활용하여 코로나19 시기 고령자의 삶의 만족도 변화 양상을 명확히 파악할 필요가 있다.

기존 국내의 연구들은 경제, 건강, 사회관계 등 다양한 측면을 고려하여 고령자의 삶의 만족도에 영향을 미치는 요인들을 탐구해왔다(고혜진, 정해식, 2022; 김미혜, 문정화, 성기옥, 2014; 서예린, 박자경, 고귀영, 2021; 왕연연, 허만세, 김영숙, 2022; 유재남, 2016; 정운영, 정세은, 2011; 조동훈, 2015; 차은진, 김경호, 2015; 채종훈, 서정원, 2019; 현은민, 2020). 그러나, 코로나19가 고령자의 삶의 질에 큰 영향을 미쳤을 것으로 예상되에도 불구하고, 코로나19 시기 고령자의 삶의 만족도 변화에 초점을 맞춰 영향요인을 살펴본 국내의 연구는 다소 제한적이다(남궁은하, 2021; 성기옥, 김수진, 문정화, 2021; 오종석, 손세호, 안상화, 2023; 이서연, 장미나, 2022). 특히, 코로나19를 기준으로 시간의 흐름에 따른 구체적인 변화 양상을 정확하게 파악하기 위해서는 동일 표본을 기반으로 두 시점에서 수집된 자료를 비교할 필요가 있으나, 기존 연구들은 코로나19로 인해 체감되는 부정적 변화를 조사하거나(남궁은하, 2021; 성기옥 외, 2021), 여러 시점의 횡단 조사자료를 비교하였다(이서연, 장미나, 2022). 또한, 종단자료를 사용한 연구의 경우에도(오종석 외, 2023) 삶의 만족도를 단일 문항으로 측정하여 종속변수로서 다양한 영역의 삶의 만족도를 동시에 고려하지 못했다는 한계가 있다.

삶의 만족도가 다양한 영역에 따라 그 수준이 상이하게 나타날 수 있다는 점을 고려하면(Schimmack, 2008), 이를 측정하기 위해 관련 지표를 포괄적으로 구성해야 한다. 이 경우, 유사한 지표 특성을 보이는 개인끼리의 유형화를 통해 분류 집단 간 차이를 확인할 수 있는 개인 중심 접근법(Person-centered Approach)의 적용이 효과적일 수 있다. 따라서 본 연구에서는 코로나19 유행 시기 중 제1기와 제2기를 코로나19 초기, 사회적 거리두기가 해제된 2022년 4월 이후를 코로나19 후기로 명명하고, 각 시점에 조사된 자료를 바탕으로 잠재전이분석(Latent Transition Analysis)을 실시하였다. 잠재전이분석은 잠재프로파일분석(Latent Profile Analysis)을 종단적으로 확장한 것으로, 시간의 흐름에 따른 잠재집단의 변화 양상을 살펴볼 수 있다는 특징을 지닌다(Nylund-Gibson et al., 2023). 이에 본 연구에서는 코로나19 초기와 후기 각 시점에서 고령자의 삶의 만족도 유형을 분류하고, 시간의 흐름에 따른 고령자의 삶의 만족도 변화 양상을 살펴보고자 했다. 나아가, 팬데믹 상황에서 상대적으로 열악한 여건에 놓이기 쉬운 고령자의 삶의 만족도 변화에 영향을 미치는 요인을 확인함으로써, 이후 이와 유사한 위기 상황이 발생할 경우에도 고령자가 보다 양질의 삶을 영위할 수 있도록 대응 전략을 탐색하고자 하였다. 이러한 연구목적을 달성하기 위한 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 코로나19 초기(2020년, 이하 1차 연도)와 후기(2022년, 이하 2차 연도) 고령자의 삶의 만족도 유형은 각각 몇 개로 분류되며, 각 유형의 특징은 어떠한가?

둘째, 1차 연도와 2차 연도 고령자의 삶의 만족도 유형의 전이 양상은 어떠한가?

셋째, 1차 연도와 2차 연도 고령자의 삶의 만족도 유형의 분류와 전이에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?

II. 이론적 배경

1. 삶의 만족도

삶의 만족도(Life Satisfaction)는 개인이 선택한 기준에 따른 삶의 질에 대한 인지적 평가로 정의되며(Shin

& Johnson, 1978; Pavot & Diener, 1993), 주관적 삶의 질(Subjective Quality of Life) 또는 주관적 웰빙(Subjective Well-being)의 개념과 혼용되어 쓰이는 경우가 많다. 주관적 삶의 질은 사회적 지표를 활용하여 측정되는 객관적 삶의 질과 대응되는 개념으로(Cummins, 2000), 삶의 질을 개인이 주관적으로 평가한다는 맥락에서 주관적 웰빙(Subjective Well-Being: SWB)을 통해 측정될 수 있다(Diener & Suh, 1997). 이 때 주관적 웰빙은 한 개인의 경험 안에서 주관적으로 평가되는 삶의 여러 영역에 대한 종합적인 판단으로 정서적·인지적 영역을 모두 포괄하는 다차원적 개념으로 정의되며(Diener, 1984), 주관적 웰빙의 세 가지 구성 요소로 긍정적·부정적 정서와 더불어 삶의 만족도가 제시되고 있다(Andrews & Withey, 1976). 따라서, 삶의 만족도는 주관적 웰빙의 구성 요소 중 하나이자, 주관적 삶의 질의 하위 요소 중 정서적 요소가 아닌 인지적 요소에 초점을 두는 것이라고 할 수 있다(Pavot & Diener, 2008). 국내의 사회조사 자료들은 주관적 웰빙을 측정하기 위해 주로 삶의 만족도를 조사하였으며, 긍정적·부정적 정서와 행복감, 삶의 의미와 가치 등을 함께 조사하기도 하였다(한준, 2020).

Diener, Sah, Lucas, & Smith(1999)는 삶의 만족도가 구체적인 삶의 영역에 따라 상이할 수 있음을 고려하여 ‘영역별 만족도(Domain Satisfaction)’를 주관적 웰빙의 하위 요소로 추가하였다. 주관적 웰빙은 전반적 삶의 만족도뿐만 아니라 영역별 삶의 만족도를 함께 고려하여야 더욱 포괄적으로 측정될 수 있으며(Heller, Watson, & Ilies, 2006; Leung, Cheung, & Liu, 2011; Pavot & Diener, 2008), 영역별 삶의 만족도를 결정하는 요인들의 탐색을 통해 전반적인 삶의 질 결정 요인에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있다(Schimmack & Oishi, 2005). 영역별 만족도에 관한 선행연구를 살펴보면, Cummins(1996)는 물질적 웰빙, 건강, 생산성, 친밀성, 안전, 사회, 감정적 웰빙의 7가지 영역을 제안하였으며, WHO에서 삶의 질 측정을 위해 개발한 WHOQOL-100의 간소화된 형태인 WHOQOL-BREF의 경우 물리적 건강, 심리적 요인, 사회적 관계, 환경적 요인의 4가지 영역으로 구분하여 측정하였다(The Whoqol Group, 1998). Van Praag, Frijters, & Ferrer-i-Carbonell(2003)의 연구에서는 건강, 경제적 상황, 일, 가정, 여가, 환경의 6가지 영역을 제시하고, 해당 영역들의 만족도와 전반적 삶의 만족도 간의 연관성을 확인하였으며, Rojas(2006)의 연구에서는 건강, 경제, 직업, 가족, 친구, 여가, 사회적 환경의 7가지 영역을 제시하였으나, 개인마다 중요하게 여기는 영역이 상이하며 영역 간 관계 또한 복잡적임을 강조하였다.

노인학에서 삶의 만족도는 고령자의 주관적 삶의 질을 평가하기 위한 중요한 지표이자(왕연연 외, 2022), 성공적 노화와 높은 수준의 주관적 웰빙을 위한 필요조건이다(Fisher, 1995). 한편, Cutler(1979)는 삶의 만족도의 요인 구조가 연령층에 따라 상이하며 생애 주기에 따라 ‘좋은 삶’을 구성하는 영역이 상이함을 주장하였고, 노인학 연구에서 이러한 점이 고려되어야 함을 강조하였다. 과거에는 고령자를 대상으로 한 주관적 삶의 질 측정을 위해 SF-36과 같이 건강 상태만을 묻는 측정 도구들이 주로 사용되었으나(Bowling, 2009), 비교적 최근에는 삶의 만족도와 영역별 만족도의 다차원성에 기반하여 하위 요인을 분석하는 시도가 진행되어왔다. Bowling(2009)은 고령자의 영역별 삶의 질에 초점을 맞춘 측정 도구인 OPQOL을 제안하였으며, 하위 영역으로 전반적 삶, 건강, 사회적 관계와 참여, 독립성, 통제성, 가정과 이웃, 심리 및 감정적 웰빙, 경제적 환경, 종교/문화의 9가지를 제시하였다. 국내에서는 이형석 외(2003)가 개발한 노인 삶의 질 척도(GQOL)에서 신체적 건강, 심리적 건강, 사회관계 및 경제 수준, 물리적 환경의 4요인 구조를 채택하였으며, 김동배(2008)의 연구에서 개발한 성공적 노화 척도의 경우 자율적 삶, 자기완성 지향, 적극적 인생 참여, 자녀에 대한 만족, 자기수용, 타인수용의 6요인 구조를 채택하고 있다. 서울시 고령자를 대상으로 삶의 질 척도를 개발한 이경욱(2008)의 연구에서는 신체적 건강, 심리적 안녕, 경제적 안녕, 사회적 관계, 사회활동, 사회환경의 6개 요인을 포함하고 있다.

위의 연구 결과를 종합해보았을 때, 측정 도구에 따라 고령자의 삶의 만족도를 측정하는 도구의 하위 요인과 문항의 종류가 매우 상이하고 세분화되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 그러나 영역별 만족도의 관점에서 보았을 때, 대부분의 측정 도구에서 공통적으로 건강, 경제, 관계 관련 요인들이 삶의 만족도 측정을 위한 하위 영역으로

나타났다. 따라서 본 연구에서는 고령자의 삶의 만족도가 주로 건강, 경제, 관계 요인들에 관한 개인의 주관적인 평가에 기반하여 결정되는 것으로 보고, 해당 영역들에 대한 만족도를 지표 변수로 선정하여 삶의 만족도를 다차원적으로 측정하고자 하였다.

2. 코로나19와 고령자 삶의 만족도

코로나19 시기 고령자 삶의 만족도의 변화에 관한 기존의 연구 결과는 다소 혼재되어 나타나고 있다. 국내의 경우, 주로 코로나19 이전과 이후 시기에 측정된 횡단자료의 비교를 통해 변화 양상을 파악할 수 있었다. 먼저 한국행정연구원에서 발표하는 사회통합실태조사의 통계에 따르면, ‘현재 삶에 어느 정도 만족하는지’를 10점 척도로 묻는 질문에 대한 65세 이상 인구의 삶의 만족도 평균은 2020년에 5.6점에서 2021년에 6.0점, 2022년 6.3점으로 점점 증가하는 추세를 보이고 있었다(한국행정연구원, 2023). 통계청에서 매년 발간되는 고령자 통계에서는 ‘자신의 생활을 전반적으로 고려할 때 현재 삶에 어느 정도 만족하는지’를 묻는 질문에 긍정적으로 응답한 65세 이상 인구의 비중이 2020년 33.5%에서 2021년 25.0%로 낮아졌다가 2022년 34.3%로 다시 높아지는 것으로 나타났다(통계청, 2023a). 한편, 코로나19 이후 국내 고령층의 삶의 만족도 변화를 분석한 연구들에 따르면, 약소하게 증가했거나(이서연, 장미나, 2022), 유의한 변화가 나타나지 않은 것으로 보고된다(고영근, 안태현, 2023; 여유진, 2022). 이러한 추세의 차이는 코로나19 시기 설문조사가 시행된 시점이나 문항의 내용, 척도의 구성 등에 따라 상이한 것일 수 있다. 그러나 이러한 결과들은 기술통계를 비교한 것에 불과하며, 각 시점마다 서로 다른 표본을 대상으로 삶의 만족도를 조사한 결과라는 한계를 지니고 있다.

한편 해외 사례의 경우, 한국과 달리 고령자의 삶의 만족도가 은퇴 이후 서서히 증가하는 것으로 알려져 있어 동일한 기준으로 해석하기에는 제한적일 수 있으나, 동일 표본에 기반하여 코로나19 시기 삶의 만족도의 종단적 변화를 확인한 연구들이 다수 존재한다. Wettstein, Nowossadeck, & Vogel(2022)의 연구에서는 2017년 67세였던 독일인 표본의 삶의 만족도가 2020년 증가한 것으로 보고되었다. Araki(2022)는 일본인 패널 자료를 활용하여 2020년과 2021년 삶의 만족도를 측정한 결과를 비교하였는데, 특히 65세 이상 연령층의 삶의 만족도가 청년층보다 더 크게 향상된 것을 확인하였다. 또한, 국내 동일 표본에 기반한 오종석 외(2023)의 연구에서는, 코로나19 시기에 독거노인의 삶의 만족도가 증가한 것으로 나타났다. 해당 결과들은 고령층이 팬데믹과 같은 위기 상황에서도 오랫동안 축적된 경험을 바탕으로 내적 기준과 우선순위를 보다 효과적으로 조정하여 긍정적 감정을 증진했을 가능성을 제시한다(Araki, 2022). 이처럼 고령자들의 빠른 적응을 가능하게 하는 심리적 자원은 건강 자원이 감소하는 시기임에도 불구하고, 정신적 건강이 상대적으로 양호하게 유지되는 데 있어 결정적 역할을 하는 것으로 알려져 있다(Foster, 1997; Takashima, Onishi, Saeki, & Hirano, 2020). 유사한 맥락으로, 여러 시점 횡단 자료를 사용한 연구들에서도 공통적으로 코로나19의 부정적 영향이 연령에 따라 조절되는 경향이 있었으며, 청년들에 비해 고령층의 삶의 만족도는 더 적은 폭으로 감소한 것으로 나타났다(여유진, 2022; Ausín, González-Sanguino, Ángel Castellanos, Saiz, & Muñoz, 2022; Bidzan-Bluma et al., 2020). 또한, 사회적 지원 수준이나 건강상태가 보호요인으로 작용하는 것으로 보고되었다(Ausín et al., 2022). 코로나19 이후 건강에 대한 관심이 증대되고, 가족과 보내는 시간이 길어지며 일과 삶의 균형이 재조명되고 새로운 도전에 대한 욕구가 생겨나는 등 긍정적 측면이 존재했다는 연구도 존재한다(Center for Ageing Better, 2020). 이러한 연구 결과들을 고려하면, 코로나19 시기 취약한 상황에 놓이기 쉬운 연령층임에도 불구하고 고령자들의 삶의 만족도가 예상보다 크게 감소하지 않았을 것으로 가정해 볼 수 있다. 그러나 앞서 언급한 연구들은 삶의 만족도가 영역에 따라 다양하게 나타날 수 있음에도 전반적인 삶의 만족도를 단일 문항으로 측정하였다는 한계가 있다. 따라서, 본 연구에서는 여러 시점에 걸쳐 동일한 표본을 대상으로 삶의 만족도를 조사한 패널 데이터를 활용하여 코로나19 시기 고령자의 삶의 만족도를 살펴보고자 하였으

며, 삶의 만족도의 다양한 영역을 포괄하여 그 변화를 살펴보고자 하였다.

3. 삶의 만족도 영향요인

고령자의 삶의 만족도에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있다(조은희, 홍상욱, 2023). 특히, 노년기는 경제 활동의 감소, 신체 능력의 저하, 사회적 활동의 감소를 경험하는 시기이므로, 이러한 특징을 반영해 인구통계학적 요인을 비롯한 경제 요인, 건강 요인, 사회관계 요인이 삶의 만족도를 좌우할 요소로서 어떠한 영향력을 미치는지 파악해야 한다.

우선 본 연구에서는 인구통계학적 요인으로 성별, 나이, 학력을 포함하였다. 성별은 주요한 인간의 생태학적 특성 중 하나로, 성별에 따라 신체, 경제, 사회적 차이(김미령, 2012)가 나타나며 이에 따라 노년기의 삶의 만족도도 다르게 나타날 수 있다. 65세 이상 노인을 대상으로 한 다수의 선행연구에서는 남성 노인의 삶의 만족도가 여성 노인의 삶의 만족도보다 높게 나타났다(김혜연, 2020; 최효진, 이홍직, 2019; 홍주연, 2018). 다만 경제적 취약계층에 한한 연구에서는 남성 노인이 대체로 여성 노인에 비해 삶의 만족도가 낮은 것으로 보고된 바 있다(전은영, 최연희, 2010). 다음으로, 나이는 삶의 만족도 연구에서 주요한 영향요인으로 확인되었으며, 선행연구에서는 대부분 나이가 증가할수록 고령자의 삶의 만족도가 저하되는 것으로 나타났지만(김미령, 2012; 서경숙, 김재태, 2023; 정영해, 조유향, 2014), 나이에 따라 삶의 만족도에 큰 차이가 없었다고 밝힌 연구도 존재한다(김은경, 2017). 마지막으로 고령자의 학력이 높을수록 신체적, 정신적 건강도 양호하며 사회적 활동도 활발하게 이루어진다는 연구 결과를 바탕으로(정경희, 2012), 학력이 삶의 만족도 인식에 미칠 긍정적 영향을 예측할 수 있다. 이전의 연구에서도 일관적으로 학력이 높을수록 노년층의 삶의 만족도가 높은 것으로 나타났다(강희순, 김지인, 2022; 반상진, 임효진, 조영재, 이진권, 2015; 정영해, 조유향, 2014; 한형수, 2008; 황여정, 김수혜, 2010). 따라서 본 연구에서는 고령자의 삶에 영향을 미치는 것으로 알려진 성별, 나이, 학력이 삶의 만족도 잠재프로파일 분류에도 동일한 영향을 미칠지 확인하고자 하였다.

고령자의 경제 요인에 따라서도 삶의 만족도 수준이 달라질 수 있다. 실제로 개인의 부채, 부동산, 금융 자산 등 다양한 경제 요인은 고령자의 삶의 만족도에 유의한 영향을 미치면서(강소랑, 문상호, 2011; 김창환, 2015; 서경숙, 김재태, 2023), 노후 생활에 경제적 여유가 가지는 중요성을 드러냈다. 다만 고령자의 전반적인 경제적 수준이 청장년층에 미치지 못할 것을 고려할 때 개인적 자산보다는 가구 수준의 자산이 경제적 상태를 나타내기에도 적합한 변수(김학주, 2017)라는 연구를 근거로, 본 연구에서는 다양한 자산의 형태 중에서도 가구 총자산이 경제 요인으로서 삶의 만족도에 미치는 영향을 살펴보았다. 또한, 고령자의 노동 참여도 경제 요인으로서 삶의 만족도에 영향을 미칠 수 있으나, 그 영향력에 대해서 다양한 의견이 존재한다. 송시영, 전해정, 최봄이(2020)는 노동 참여가 삶의 만족도를 높이는 긍정적 효과를 일부 보이고 있음을 밝혔으나, 최아영과 윤현숙(2012)은 많은 노인의 경제 노동 참여는 생활고가 이유이며, 경제 노동에 참여할수록 삶의 질도 낮아진다고 주장하였다. 이에 본문에서는 고령자의 노동 여부를 영향요인으로 포함하여 삶의 만족도 프로파일 분류 및 전이에 미치는 영향력을 재검토하였다.

또한 노년기는 급격한 신체 노화가 이루어지는 시기로, 건강과 관련한 다양한 요인들이 삶의 질에 영향을 미칠 수 있다. 특히 신체 능력의 저하에 따른 일상생활의 어려움은 건강과 관련한 삶의 질을 낮출 수 있는 요소이다(손누리, 김규나, 서영준, 2022). 고령자의 신체 능력은 독립적 일상생활을 위한 일상생활 수행 능력(Activity of Daily Livings; ADL)과 도구적 일상생활 수행 능력(Instrumental Activity of Daily Livings; IADL)으로 측정할 수 있다(임영아, 조영재, 2017). 선행연구에서는 고령자의 ADL과 IADL 모두 장기 관찰 시 시간의 흐름에 따라 악화됐고(배다영, 박은빈, 2022), 다양한 고령자 집단에서 ADL이나 IADL의 제한이 많을수록 삶의 질이 낮은 것으로 보고되었

다(남상권, 심옥수, 2011; 서순림, 김미한, 2014; 황미구, 2008). 한편, 노년기는 노화로 인하여 주변인의 상실 및 고독 등 여러 부정적 경험을 겪게 되는 만큼, 타 연령대에 비하여 우울감을 느끼며 심리적 건강이 저하될 가능성이 높다(오창석, 2012). 특히 고령자의 우울증은 인지 기능의 저하를 동반하는 경우가 많고(황미구, 2008), 노인 자살의 근본적인 원인이 되기에(허준수, 유수현, 2002) 더욱 중요하게 관찰되어야 한다. 이와 관련하여 다양한 연구에서 우울이 삶의 만족도에 미치는 부정적 영향력을 확인한 바 있다(김은하, 이지원, 2009; 연병길 외, 1999; 최미영,곽현근, 박현식, 2014; 황미구, 김은주, 2008). 마지막으로 운동은 노인의 건강과 체력을 향상해 일상생활에 긍정적인 도움을 주는 요인이다(안찬우, 이원미, 2021). 특히 노년층에게 운동은 타인과의 교류의 장으로도 기능할 뿐만 아니라(권오정, 2020), 심리적 건강을 개선해 삶의 만족도에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다(이윤표 외, 2018). 본 연구에서도 신체 건강과 심리 건강을 대표하는 요인으로 일상생활 도움 필요 정도와 우울, 그리고 규칙적 운동 여부를 포함하여, 삶의 만족도 잠재프로파일 분류 및 전이 가능성에 미치는 영향력을 파악하였다.

마지막으로, 고령자의 사회적 관계는 이전보다 급속히 그 범위가 줄어들는데, 이 시기에 주변인들로부터 받는 관심과 도움은 스트레스 상황 속에서 삶의 만족도를 유지하기 위한 중요한 자원이 된다(손주희, 이명진, 2018; Krause, 2006). 일반적으로도 사회관계는 고령자의 삶의 만족도에 긍정적인 영향을 미치는데, 서경숙과 김재태(2023)는 만남과 모임이 잦을수록 삶의 만족도가 높아지며, 사회관계를 통해 우울을 예방하거나 낮출 수 있다고 보았다. 취미, 근로, 종교성 모임과 같은 다양한 사회관계 중에서도 특히 친목모임은 노인이 건강한 삶을 누리게 하는 요인으로 언급되었다(김진원, 임구원, 2019; 문준호, 송명근, 이원석, 당약함, 2021). 이미숙(2010)의 연구에서도 친목모임은 고령자가 겪는 만성 질환에 의한 우울 증상을 완충하며, 정서적 지원을 제공하는 가족 외부 관계망으로서의 역할을 수행하는 것으로 나타났다. 본 연구는 코로나19 상황에서는 가족을 제외한 외부인과의 대면 접촉이 제한되며 사회관계의 빈도가 줄어들고 자유로운 외부 활동이 어려워진 만큼, 사회관계의 감소가 노인의 삶의 만족도에 미치는 부정적 영향력이 다른 때보다 더 높게 나타날 가능성이 있다고 판단하였다. 따라서, 친목모임을 사회관계를 대표하는 변인으로 가정해 노인의 삶의 만족도 프로파일 분류 및 전이에 미치는 영향을 살펴보았다.

III. 연구 방법

1. 분석 자료 및 연구 대상

본 연구는 한국고용정보원에서 실시한 고령화연구패널조사의 8차와 9차 자료를 사용하였다. 고령화연구패널조사는 고령자를 대상으로 효과적인 사회경제정책 수립을 위해 사회, 경제, 심리, 건강, 인구학적 요인 등 삶의 전반을 포괄하는 다양한 요인을 조사한 자료이다. 8차 자료는 2020년 8월부터 12월에 조사되었으며, 이는 코로나19 제1기와 2기에 해당하므로 코로나19 초기 자료로 볼 수 있다. 9차 자료는 사회적 거리두기가 해제된 이후 시점인 2022년 8월부터 12월 사이에 조사되었으므로 코로나19 후기 자료에 해당한다. 8차 자료의 응답자 수는 총 6,488명, 9차 자료의 응답자 수는 총 6,057명으로 해당 시점에서 93.4%의 표본 유지율을 보였다. 본 연구에서는 노인을 만 65세 이상 성인으로 규정하여, 코로나19 초기인 1차 연도(2020년, 8차 자료)에서 만 65세 이상으로 응답한 4,405명을 대상으로 분석을 시행하였다. 1차 연도 응답자의 성별은 남성 41.8%, 여성 58.2%이었다. 코로나 후기인 2차 연도(2022년, 9차 자료)에서는 1차 연도 표본 중 477명이 탈락하였으며, 탈락한 표본을 제외한 3,928명 중 남성이 41.3%, 여성이 58.7%로 나타났다. 1차 연도 기준 탈락한 표본의 평균 나이는 81.6세, 건강상태는 1.8로, 탈락하지 않은 표본(나이 75.3세, 건강상태 2.1)에 비해 나이가 약 6세 많고, 건강상태가 더 나쁜 것으로 나타났다.

2. 측정 도구

1) 삶의 만족도 잠재프로파일

고령자의 삶의 만족도의 잠재프로파일을 구분하기 위한 변수로 1차 연도와 2차 연도 자료에서 자신의 경제상태, 자신의 건강상태, 배우자와의 관계, 자녀와의 관계, 전반적인 삶의 질에 대한 만족도를 묻는 5개의 문항을 활용하였으며, 문항의 세부 내용은 <표 1>에 제시하였다. 5개 영역의 삶의 만족도는 0점부터 100점까지 10점 단위로 구성되었다.

<표 1> 삶의 만족도 잠재프로파일 변수

요인	문항
경제상태에 대한 만족도	자신의 건강상태에 대해서 어느 정도 만족하고 계십니까?
건강상태에 대한 만족도	자신의 경제상태에 대해서는 어느 정도 만족하고 계십니까?
배우자와의 관계에 대한 만족도	배우자와의 관계에 대해서는 어느 정도 만족하고 계십니까?
자녀와의 관계에 대한 만족도	자녀와의 관계에 대해서는 어느 정도 만족하고 계십니까?
전반적인 삶의 질에 대한 만족도	전반적인 삶의 질(행복감)에 대해서는 어느 정도 만족하고 계십니까?

출처: “고령화연구패널조사”, 한국고용정보원, 2020-2022, 고용조사분석시스템, 고령화연구패널조사 8-9차 원자료 및 구조변환자료, 2024. 03. 23. 검색, URL<https://survey.keis.or.kr/klosa/klosadownload/List.jsp>

2) 삶의 만족도 잠재프로파일 영향요인 및 전이 영향요인

고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일 분류의 영향요인으로서는 인구통계학적 요인인 성별, 나이, 학력, 경제 요인인 가구 총자산과 노동 여부, 건강 요인인 일상생활 도움 필요 정도, 우울 및 규칙적 운동 여부, 사회관계 요인인 친목모임 참여 여부를 포함하였다. 1차 연도와 2차 연도에서 잠재프로파일 분류에 영향을 미치는 요인을 각각 검증하기 위해 각 연도에서 측정된 변수를 모두 활용하였다. 전이 영향요인으로서는 인구통계학적 요인을 제외하고 1차 연도에서 측정된 가구 총자산, 노동 여부, 일상생활 도움 필요 정도, 우울, 규칙적 운동 여부, 친목모임 참여 여부를 포함하였다.

인구통계학적 요인 중 성별은 남성을 0, 여성을 1로 코딩하여 사용하였다. 학력은 4개의 서열척도로 구성된 값을 활용하였다(1=초등학교 졸업 이하, 2=중학교 졸업, 3=고등학교 졸업, 4=대학교 졸업 이상). 가구 총자산은 자산을 만원 단위로 응답한 자료를 로그 변환한 값을 사용하였다. 노동 여부는 현재 노동 여부를 묻는 문항에 ‘아니오’라고 응답한 경우 0, ‘예’라고 응답한 경우 1로 코딩하였다. 일상생활 도움 필요 정도는 기본적인 일상생활 수행 능력 척도인 ADL(Activities Daily Living)과 도구적 일상 활동 수행 능력을 평가하는 척도인 IADL(Instrumental Activities of Daily Living) 지수를 합산하여 사용하였다. 합산된 문항의 점수 범위는 0점부터 17점으로 점수가 높을수록 타인의 도움이 필요하다는 것을 의미한다. 우울은 노인과 만성질환자를 대상으로 개발된 미국 CES-D20을 축약한 한국판 CES-D10 척도(Boston form)(배성우, 김이영, 도문학, 김혜지, 박병선, 2020)로 측정되었으며, 각 문항은 0부터 10의 값으로 구성된다. 점수가 높을수록 우울감이 높은 것을 의미하도록 10개 중 일부 문항은 역코딩하여 평균값을 도출하였으며, 신뢰도는 1차 연도 .849, 2차 연도 .850으로 나타났다. 규칙적 운동 여부는 주1회 이상 규칙적인 운동을 하는지 묻는 문항에 ‘아니오’라고 응답하였으면 0, ‘예’라고 응답하였으면 1로 코딩하였다. 친목모임 참여 여부는 친목모임(계모임, 노인정 등)에 대한 참여 여부를 묻는 문항에 ‘아니오’라고 응답한 경우 0, ‘예’라고 응답한 경우 1로 코딩하였다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 잠재프로파일분석(LPA: Latent Profile Analysis)의 종단적 확장 모형인 잠재전이분석(LTA, Latent Transition Analysis)을 사용하여 고령자가 지각하는 삶의 만족도 유형을 탐색하고, 코로나19 초기와 후기 유형의 변화를 확인하며 이에 영향을 미치는 요인을 검증하고자 하였다. 잠재프로파일분석은 개인의 응답 패턴에 기반하여 모집단 내 서로 다른 특성을 가진 하위 집단을 도출할 수 있는 방법으로, 기존의 변수중심적 방법과 달리 개인의 특성에 초점을 맞춘 분석 방법이다(Bergman & Magnusson, 1997). 잠재전이분석은 앞선 시점에서 한 잠재집단에 속했던 개인이 이후 시점의 특정 잠재집단으로 전이될 가능성을 전이확률로 추정한다(Collins & Lanza, 2009). 본 연구에서는 잠재전이분석 시 공변인(Covariate)의 효과 추정을 위해 3단계 분석 방법(3-step Approach)을 사용하였다(Vermunt, 2010). 이는 잠재집단 분류와 공변인 추정을 독립적으로 실시하는 방법으로, 두 과정을 동시에 수행하는 1단계 방법(1-step Approach)과 달리 공변인이 잠재집단 분류에 미치는 영향을 통제하여 보다 일관적이고 정확한 결과를 산출한다는 장점이 있다(Asparouhov & Muthén, 2014; Nylund-Gibson, Grimm, Quirk, & Furlong, 2014).

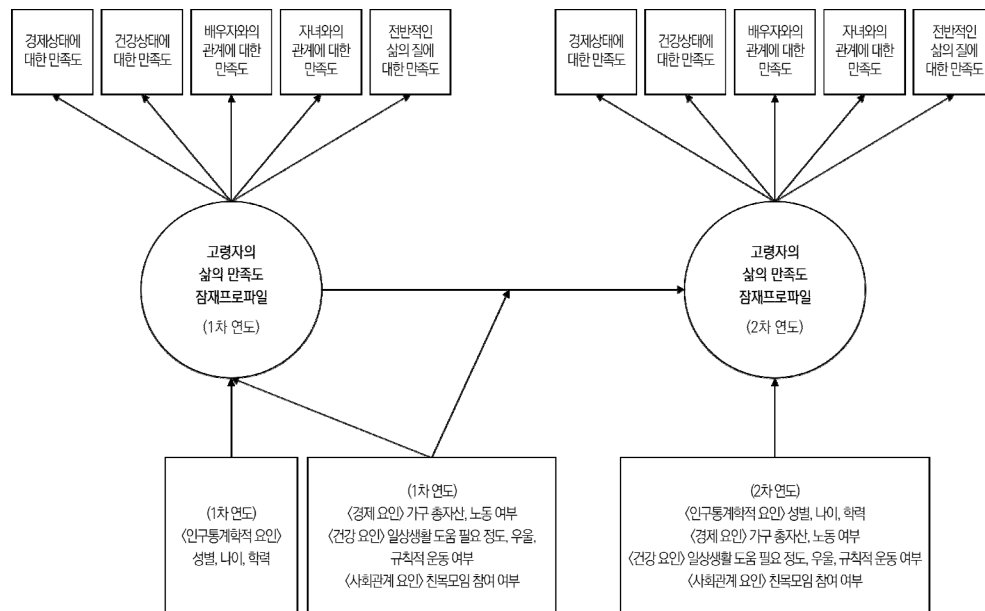
3단계 추정 방법의 분석 절차는 다음과 같다. 우선 각 시점에서 공변인을 포함하지 않은 잠재프로파일 분석을 통해 최적의 집단 수를 결정한다. 잠재프로파일 수는 정보지수, 모형 비교검증, 분류의 질과 잠재프로파일 소속 비율, 모형의 해석 가능성을 종합적으로 고려하여 결정한다. 대표적인 정보지수로는 AIC(Akaike Information Criteria; Akaike, 1974), BIC(Baysian Information Criterion; Schwarz, 1978), SABIC(Sample-size Adjusted BIC; Sclove, 1987)가 있으며, 각 정보지수의 값이 작을수록 모형이 잘 분류되었음을 나타낸다. 모형 비교검증 지표로는 LMR LRT(Lo-Mendell-Rubin adjusted Likelihood Ratio Test; Lo, Mendell, & Rubin, 2001)와 BLRT(parametric Bootstrapped Likelihood Ratio Test; Peel & McLachlan, 2000)를 확인한다. 이는 잠재프로파일 개수가 $k-1$ 개와 k 개인 모형을 비교하여 차이를 검증하는 방법으로, k 개 잠재프로파일 모형에서 각 통계치의 p -value가 유의하지 않다면 $k-1$ 개인 모형을, 유의하다면 k 개인 모형을 선택한다. 분류의 질을 나타내는 Entropy는 1에 가까울수록 분류 정확도가 높음을 의미하며, 0.6 이상인 경우 분류의 질이 중간 이상, 0.8 이상이면 높다고 해석할 수 있다(Barnum et al., 2010).

한편, 각 시점의 최종 잠재프로파일 수가 동일한 경우, 두 시점의 잠재프로파일이 동일한 의미를 갖는지 확인하기 위해 측정동일성(Measurement Invariance) 검증을 시행할 수 있다. 측정동일성이 성립하면 두 시점에서의 측정 모수 추정치가 같게 되며, 잠재프로파일 간 의미가 동일하다고 결론 내릴 수 있다(Collins & Lanza, 2009). 측정동일성 검증은 측정동일성이 성립한다는 제약을 가한 모형과 제약을 가하지 않은 모형, 즉 내재된 모형 간 비교이므로 차이검증의 방식이 요구된다. 그러나 분포에 기반한 차이검증의 경우 표본 크기가 클 때 영가설을 더 쉽게 기각하는 경향이 있으므로, 실제로 집단 간 차이가 작을지라도 통계적으로 유의한 결과가 도출될 수 있다. 따라서 일반적으로 AIC나 BIC와 같은 정보지수를 함께 고려하는 것이 권장된다(Collins & Lanza, 2009). 이에 본 연구에서는 측정동일성 성립 여부를 판단하는 지표로 AIC, BIC 및 SABIC를 포함하였다.

다음으로, 각 시점의 잠재프로파일 분석에서 도출된 개인의 사후확률에 따라 개인을 잠재집단에 할당하고, 분류오류를 계산한다. 이때 앞선 과정에서 측정동일성이 성립되었다면, 각 시점의 잠재프로파일별 문항반응확률을 동일한 값으로 제약하고 분석을 진행한다. 마지막 단계에서는 앞선 단계에서 얻은 분류오류를 고정하고, 두 시점의 잠재프로파일 분석을 결합한 모형에 공변인을 포함하여 효과를 추정한다. 이때 추정된 계수는 일반적인 이항 및 다항 로지스틱 회귀분석에서와 같이 해석할 수 있다.

한편, 결측치는 완전정보 최대우도(FIML, Full Information Maximum Likelihood) 추정에 기반하여 처리하였다. 일반적으로 결측값을 포함하는 자료에 잠재프로파일 분석을 적용할 경우, 완전정보 최대우도 추정 방법이 가장

권장되며, 이 방법은 완전제거법(Listwise Deletion) 등 다른 결측 처리 방법에 비해 모형 수렴률, 모수 추정의 정확도 등에서 더 좋은 수행력을 보이는 것으로 알려져 있다(Collins & Lanza, 2009; Hagenaars & McCutcheon, 2002). 상술한 분석 과정을 수행하기 위해 Mplus 8.3을 활용하였으며, 최종 연구모형은 [그림 1]과 같다.



[그림 1] 연구 모형

IV. 연구 결과

1. 기술 통계

본 연구에서 활용한 변수들의 기술통계 분석 결과는 <표 2>와 같다. 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일을 구성하는 지표들의 평균은 모두 1차 연도 대비 2차 연도에 더 높게 나타났다. 본 연구의 관심변수인 삶의 만족도 지표변수들의 경우, 배우자 및 자녀가 없거나 미응답한 사례가 다수 존재하였다. 이처럼 잠재프로파일 분석에서 일부 지표변수에만 결측치가 존재하는 경우, 완전정보 최대우도 추정 방법에 기반하여 결측치가 처리되며, 해당 사례를 분석에 포함할 수 있다(Ferguson, Moore, & Hull, 2020).

2. 잠재프로파일 수 결정

각 시점별 최적의 잠재프로파일 개수를 결정하기 위해 정보지수(AIC, BIC, SABIC), 모형 비교검증(LMR LRT 및 BLRT의 p-value), 잠재프로파일별 소속 비율을 확인한 결과는 <표 3>과 같다. 1, 2차 연도 모두 잠재프로파일 수가 증가할수록 정보지수는 지속적으로 감소하였다. 이러한 경우 정보지수가 가장 큰 폭으로 감소하는 지점인 'Elbow Point'를 잠재프로파일 개수 선정의 근거로 고려할 수 있다(Nylund, Asparouhov, & Muthén, 2007). 본 연구에서 두 시점의 정보지수는 공통적으로 잠재프로파일 수가 2개에서 3개로 증가할 때 큰 감소 폭을 보였다. 1, 2차 연도

〈표 2〉 주요 변수들의 기술통계

구분	변수	1차 연도			2차 연도		
		표본 수(결측)	평균	표준편차	표본 수(결측)	평균	표준편차
삶의 만족도 잠재프로파일 지표변수	경제상태에 대한 만족도 ¹⁾	4,404(1)	5.49	1.95	3,927(478)	5.57	1.86
	건강상태에 대한 만족도 ¹⁾	4,403(2)	5.55	2.00	3,927(478)	5.62	1.98
	배우자와의 관계에 대한 만족도 ¹⁾	2,966(1,439)	6.78	1.55	2,622(1,783)	6.79	1.49
	자녀와의 관계에 대한 만족도 ¹⁾	2,833(1,572)	6.94	1.64	2,756(1,649)	6.96	1.59
	전반적인 삶의 질에 대한 만족도 ¹⁾	4,404(1)	6.19	1.68	3,928(477)	6.23	1.64
인구통계학적 요인	성별 ²⁾	4,405(0)	0.58	-	3,928(477)	0.59	-
	나이	4,405(0)	76.01	7.43	3,928(477)	77.34	7.04
	학력	4,405(0)	1.91	1.04	3,928(477)	1.92	1.03
경제 요인	가구 총자산	4,326(79)	9.85	1.20	3,827(578)	9.97	1.27
	노동 여부 ²⁾	4,405(0)	0.23	-	3,928(477)	0.21	-
건강 요인	일상생활 도움 필요 정도	4,405(0)	1.11	3.34	3,928(477)	1.25	3.41
	우울	4,403(2)	1.62	0.52	3,927(478)	1.67	0.51
	규칙적 운동 여부 ²⁾	4,405(0)	0.40	-	3,928(477)	0.45	-
사회관계 요인	친목모임 참여 여부 ²⁾	4,405(0)	0.49	-	3,928(477)	0.51	-

1) 해당 문항은 0점부터 100점까지 10점 단위로 측정되어, 10으로 나누어 계산한 값을 표기하였음.

2) 이분변수의 경우 1(성별: 여, 노동 여부/규칙적 운동 여부/친목모임 참여 여부: 예)에 대한 응답의 비율.

〈표 3〉 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일 수에 따른 비교

잠재프로파일 개수		AIC	BIC	SABIC	Entropy	LMR	LRT	BLRT	잠재프로파일별 소속 비율(%)				
									1	2	3	4	5
1차 연도	2	70994.939	71097.184	71046.342	0.804	<.001	<.001	<.001	30.1	69.9	-	-	-
	3	69479.91	69620.496	69550.589	0.783	<.001	<.001	<.001	10.9	41.3	47.8	-	-
	4	69005.181	69184.108	69095.135	0.806	.123	<.001	<.001	4.2	41.3	9.0	45.5	-
	5	68567.1	68784.369	68676.331	0.803	.139	<.001	<.001	11.0	3.1	37.0	42.8	6.1
2차 연도	2	62526.308	62626.722	62575.881	0.818	<.001	<.001	<.001	32.3	67.7	-	-	-
	3	60995.783	61133.852	61063.946	0.795	<.001	<.001	<.001	13.3	42.7	44.0	-	-
	4	60532.589	60708.313	60619.342	0.778	.037	<.001	<.001	18.5	4.6	35.4	41.5	-
	5	60063.716	60277.096	60196.06	0.814	.020	<.001	<.001	4.6	16.8	4.3	35.1	39.3

모두 Entropy는 잠재프로파일 수가 2개일 때 가장 높았으나, 모든 잠재프로파일이 전반적으로 .8에 가까운 양호한 값을 보였다. 1차 연도의 LMR LRT는 잠재프로파일 수가 4개일 때 유의하지 않았으며, BLRT는 잠재프로파일 수에 관계없이 항상 유의하게 나타났다. 이러한 통계적 근거와 잠재집단의 해석 가능성을 종합적으로 고려하여 1차 연도의 잠재프로파일 수를 3개로 결정하였다. 한편, 2차 연도의 경우 모형 비교검증 결과는 잠재프로파일이 2개일 때부터 5개로 증가할 때까지 모두 유의하게 나타났다. 이는 해당 지표가 잠재프로파일 수 결정을 위한 적절한 근거를 제공하지 못한다는 의미이므로, 다른 지표를 활용할 것이 권장된다(Nylund-Gibson et al., 2014). 이에 2차 연도에서도 정보지수의 감소 폭이 가장 크게 나타났던 3개 잠재프로파일 모형이 가장 적절하다고 판단하였다.

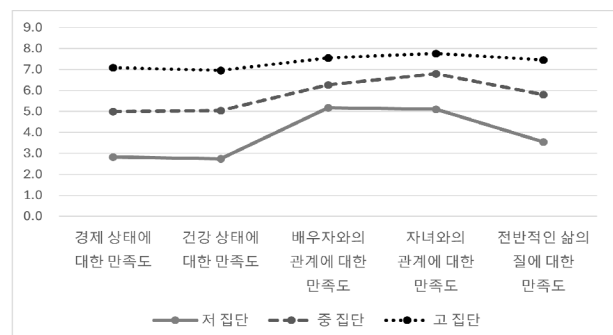
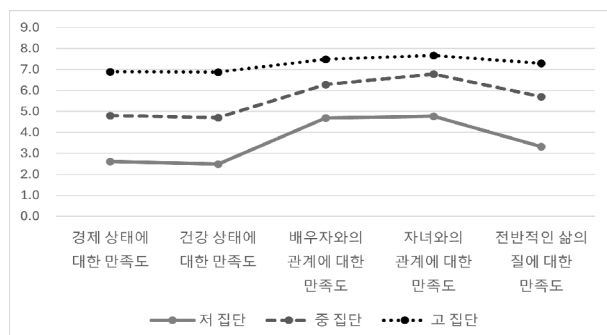
3. 잠재프로파일 특성 및 영향요인 검증

1) 잠재프로파일 특성 확인

만 65세 이상 고령인구의 삶의 만족도 잠재프로파일 특성을 확인하기 위해 집단별 문항 평균과 소속 비율을 살펴본 결과는 <표 4>에, 프로파일의 형태는 [그림 2]에 제시하였다. 먼저 1차 연도 각 집단의 특성을 살펴보면, 세 집단 중 첫 번째 집단은 삶의 만족도를 나타내는 모든 영역에서 다른 집단 대비 가장 낮은 수준을 보여 '저 집단'으로 명명하였으며, 전체의 10.9%로 가장 적은 비중을 차지하였다. 해당 집단은 특히 경제와 건강에서 삶의 만족도가 다른 집단에 비해 특히 낮은 수준으로 나타났다. 두 번째 집단은 모든 영역에서 저 집단보다는 높지만 마지막 집단보다는 낮은 수준을 보여 '중 집단'으로 명명하였으며, 전체의 41.3%가 중 집단에 속하는 것으로 나타났다. 세 번째 집단은 삶의 만족도의 모든 영역에서 가장 높은 수준을 나타낸 '고 집단'으로, 전체의 47.8%로 비중이 가장 컸다. 2차 연도의 삶의 만족도 잠재프로파일은 1차 연도와 동일하게 3개 집단으로 분류되었으며, 각 집단의 특성 또한 이전 시점과 유사한 형태를 보였다. 1차와 2차 연도 모두 잠재프로파일별 차이는 경제와 건강 영역에서 가장 크게 나타났으며, 고 집단의 경우 경제와 건강, 관계, 전반적인 삶의 질 영역에서 골고루 높은 특성을 보였으나, 중 집단과 저 집단의 경우 관계 영역보다 경제와 건강 영역에서 집단 간 큰 차이를 보였다. 잠재프로파일 비율을 살펴보면, '저 집단'의 비중이 13.3%로 가장 적었으며, '중 집단'과 '고 집단'이 각각 42.7%, 44.0%로 전체적인 양상은 1차 연도와 크게 다르지 않게 나타났으나, 2차 연도가 1차 연도에 비해 저 집단과 중 집단에 속한 사람의 비율이 높고, 고 집단에 속한 사람의 비율이 낮았다.

<표 4> 고령자의 삶의 만족도 지표별 평균 및 잠재프로파일 소속 비율

변수	1차 연도			2차 연도		
	저 집단	중 집단	고 집단	저 집단	중 집단	고 집단
경제상태에 대한 만족도	2.61	4.80	6.90	2.82	4.99	7.08
건강상태에 대한 만족도	2.48	4.70	6.88	2.74	5.05	6.95
배우자와의 관계에 대한 만족도	4.70	6.28	7.49	5.17	6.26	7.56
자녀와의 관계에 대한 만족도	4.77	6.79	7.67	5.10	6.79	7.76
전반적인 삶의 질에 대한 만족도	3.32	5.70	7.30	3.54	5.80	7.46
소속 비율(%)	10.9	41.3	47.8	13.3	42.7	44.0



[그림 2] 1차 연도(좌) 및 2차 연도(우) 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일 형태

2) 측정동일성 검증

잠재프로파일 분석 결과, 각 시점의 잠재집단 수가 동일하게 나타났으며, 두 시점에서 각 집단의 개형도 유사하게 확인되었으므로 측정동일성 검증을 실시하였다. 집단별 문항반응확률을 동일하게 제약한 모형과 제약하지 않은

모형을 비교한 결과를 <표 5>에 제시하였다. 제약 모형과 비제약 모형의 차이검증 결과는 유의하게 나타났으며 ($p < .001$), AIC 또한 제약 모형에서 근소한 차이로 크게 나타났다. 그러나 BIC와 SABIC는 제약 모형에서 더 작은 값을 보였다. 본 연구와 같이 표본 크기가 2,000 이상으로 큰 경우, 차이검증에서는 영가설을 잘못 기각하는 1종 오류가 크게 나타날 수 있다(Finch, 2015). 이에 본 연구에서는 정보지수에 기반한 결과를 우선적으로 고려하였다. 또한, 이처럼 통계적 지표들이 상충하는 경우 집단 간 문항반응확률의 차이가 질적으로 다른 의미가 있는지에 대한 판단이 핵심이 된다는 논의에 따라(Collins & Lanza, 2009), 집단 간 차이를 살펴본 결과, 크게 유의미한 차이가 발견되지 않아 본 연구는 측정동일성이 만족되었다고 판단하고 제약 모형으로 이후 분석을 진행하였다.

<표 5> 측정동일성 검증을 위한 제약 모형과 비제약 모형 비교 결과

	LL	#par	AIC	BIC	SABIC	$\Delta\chi^2(\Delta df)$, p value
제약 모형	-65221.909	29	130501.818	130687.136	130594.986	43.160(15), $p < .001$
비제약 모형	-65193.846	44	130475.692	130756.864	130617.050	

주: LL = Log-likelihood, #par = number of parameters

3) 잠재프로파일 분류 영향요인 검증

1차 연도와 2차 연도에서 고령자의 삶의 만족도 프로파일 분류에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과는 <표 6>과 같다. 삶의 만족도를 향상하기 위한 방안에 초점을 맞추고자, 준거집단은 두 시점에서 모두 저 집단으로 설정하였다. 각 영향요인의 계수는 준거집단 대비 비교집단에 속할 확률에 대한 로짓값을 의미한다. 즉 영향요인의 계수가 양수이면 해당 영향요인의 값이 클수록 준거집단 대비 비교집단에 속할 가능성이 크고, 계수가 음수이면 영향요인의 값이 클수록 비교집단 대비 준거집단에 속할 가능성이 높다고 해석할 수 있다. 먼저, 1차 연도의 잠재프로파일 분류에 영향을 미치는 요인을 살펴보면, 가구 총자산이 많을수록, 친목모임에 참여할수록 저 집단보다는 중 집단이나 고 집단에 속할 가능성이 높게 나타났다. 반면, 일상생활 도움 필요 정도나 우울이 높을수록 고 집단이나 중 집단보다는 저 집단에 속할 확률이 높았다. 학력과 노동 여부의 영향은 비교집단이 고 집단일 때에는 유의했으나, 중 집단과의

<표 6> 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일 분류 영향요인 (준거집단 : 저 집단)

시기		1차 연도		2차 연도	
비교집단		고 집단	중 집단	고 집단	중 집단
요인		계수(표준오차)	계수(표준오차)	계수(표준오차)	계수(표준오차)
인구 통계학	성별	-0.165(.179)	-0.107(.171)	-0.098(.195)	-0.002(.173)
	나이	0.000(.012)	0.000(.011)	0.021(.015)	0.020(.013)
	학력	0.469(.099)***	0.084(.098)	0.030(.109)	0.005(.100)
경제	가구 총자산	0.822(.069)***	0.434(.057)***	0.571(.105)***	0.382(.084)***
	노동 여부	0.589(.240)*	0.364(.241)	0.283(.346)	0.165(.323)
건강	일상생활 도움 필요 정도	-0.195(.048)***	-0.052(.020)**	-0.180(.051)***	-0.075(.024)**
	우울	-2.734(.184)***	-1.478(.157)***	-2.004(.203)***	-1.432(.159)***
	규칙적 운동 여부	0.312(.178)	0.228(.176)	0.610(.221)**	0.206(.200)
사회관계	친목모임 참여 여부	0.903(.178)***	0.705(.174)***	0.652(.199)***	0.050(.178)

주: * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

대비에서는 유의하지 않았다. 2차 연도에서 잠재프로파일 분류에 영향을 미치는 요인은 가구 총자산, 친목모임 참여 여부, 일상생활 도움 필요 정도, 우울 등으로 1차 연도와 유사하게 나타났으나, 학력과 노동 여부의 영향은 유의하지 않았다. 또한, 1차 연도에서는 규칙적 운동 여부의 효과가 유의하지 않았으나, 2차 연도에서는 규칙적 운동에 참여할수록 저 집단 대비 고 집단에 속할 확률이 높은 것으로 나타났다.

4. 잠재전이분석

1) 잠재프로파일 전이 양상

1차 연도와 2차 연도에서 삶의 만족도 잠재프로파일의 전이 양상을 분석한 결과는 <표 7>에 제시하였다. 전반적으로 모든 집단 내에서 1차 연도와 2차 연도에 동일한 집단을 유지할 확률이 가장 높았으나, 고 집단으로 갈수록 집단을 유지할 가능성이 높았다(저 집단 44.4%, 중 집단 65.1%, 고 집단 73.7%). 잠재프로파일 간 이동 비율을 살펴보면, 가장 낮은 삶의 만족도를 보였던 저 집단은 다른 집단에 비해 계층을 이동할 확률이 높았으며, 이동하는 경우 대부분 중 집단으로 이동하였으나(47.0%), 일부는 고 집단으로 이동하였다(8.6%). 1차 연도의 중 집단은 저 집단(13.2%)보다 고 집단(21.7%)으로 이동하는 비율이 더 높았다. 1차 연도의 고 집단은 중 집단으로 24.0%, 저 집단으로 2.3%가 전이되었다. 종합하면, 1차 연도 대비 2차 연도에서 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일은 유지되는 것이 주된 양상이었으며, 전이가 발생하더라도 저 집단에서 고 집단으로의 극단적 상향 이동이나 고 집단에서 저 집단으로의 극단적 하향 이동은 매우 낮은 확률로 일어났다.

<표 7> 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일 전이 양상 (%)

구분	2차 연도		
	저 집단	중 집단	고 집단
1차 연도	저 집단	44.4	47.0
	중 집단	13.2	65.1
	고 집단	2.3	24.0

2) 잠재프로파일 전이 영향요인 검증

다음으로, 잠재계층 전이에 대한 영향요인들의 유의성을 검증한 결과를 <표 8>에 제시하였다. 2차 연도에서 잠재집단 간 전이가 발생할 때 기준이 되는 집단인 준거집단은 저 집단으로 설정하였으며, 영향요인 계수는 잠재프로파일 영향요인 검증 결과와 유사하게 준거집단 대비 해당 집단으로 이동할 확률로 해석할 수 있다. 예를 들어, 1차 연도의 고 집단에서 2차 연도의 고 집단으로 이동하는 데 영향을 미치는 변수를 살펴보았을 때, 유의한 영향요인의 계수가 양수이면 해당 영향요인의 값이 클수록 2차 연도의 준거집단(저 집단)보다는 비교집단(고 집단)으로 이동할 확률이 높고, 계수가 음수이면 해당 영향요인의 값이 클수록 2차 연도의 고 집단 대비 저 집단으로 이동할 확률이 높다고 해석할 수 있다. 이러한 해석은 1차 연도의 고, 중, 집단에 모두 동일하게 적용된다. 결과를 살펴보면, 경제, 건강, 사회관계 요인 중 사회관계 요인인 친목모임 참여 여부만이 잠재프로파일 전이에 유의한 영향을 나타냈다. 1차 연도에서 중 집단에 속한 사람은 친목모임에 참여할수록 2차 연도에서 저 집단으로 이동하기보다 중 집단을 유지할 확률이 높았으며, 1차 연도에서 저 집단에 속한 경우, 친목모임에 참여할수록 저 집단을 유지하기보다 고 집단으로 이동할 가능성이 높았다. 즉, 친목모임 참여 여부는 삶의 만족도가 상대적으로 낮은 집단으로 이동하는 것을 방지하거나, 삶의 만족도가 높은 집단으로의 전이에 긍정적인 영향을 보였다. 한편, 1차 연도의 고 집단이 2차 연도에서

저 집단 대비 고, 중 집단으로 전이되는 데에는 본 연구에서 포함한 어떤 변수도 유의한 영향을 미치지 않았다.

〈표 8〉 고령자의 삶의 만족도 잠재프로파일 전이 영향요인 (준거집단 : 2차 연도 저 집단)

구분		2차 연도	
		고 집단	중 집단
1차 연도	요인	계수(표준오차)	계수(표준오차)
고 집단	경제	가구 총자산	-0.156(0.277)
		노동 여부	-0.422(0.620)
	건강	일상생활 도움 필요 정도	-0.240(0.202)
		우울	0.931(1.276)
		규칙적 운동 여부	0.575(0.738)
	사회관계	친목모임 참여 여부	0.748(0.571)
중 집단	경제	가구 총자산	-0.073(0.164)
		노동 여부	0.185(0.412)
	건강	일상생활 도움 필요 정도	0.098(0.075)
		우울	-0.061(0.318)
		규칙적 운동 여부	-0.227(0.329)
	사회관계	친목모임 참여 여부	0.593(0.309)
저 집단	경제	가구 총자산	0.423(0.287)
		노동 여부	0.063(1.434)
	건강	일상생활 도움 필요 정도	0.079(0.151)
		우울	-0.639(0.766)
		규칙적 운동 여부	0.431(0.971)
	사회관계	친목모임 참여 여부	1.639(0.817)*

주: * $p < .05$, *** $p < .001$

V. 결론 및 논의

본 연구에서는 고령자 집단에서 삶의 만족도 집단을 구분하여 종단적 변화를 살펴보고자 하였으며, 그 결과에 기반하여 고령자의 전반적 삶의 만족도 향상을 위한 사회 및 정책적 노력의 방향성을 제시하고자 하였다. 이를 위해 종단적 자료를 기반으로 고령자의 삶의 만족도 수준에 따른 시점별 잠재프로파일과 분류 영향요인을 검증하고, 두 시점 동안의 집단 간 전이 양상 및 전이에 영향을 미치는 요인들을 파악하였다.

본 연구에서 분류한 고령자의 삶의 만족도 잠재 프로파일은 1차 연도와 2차 연도 모두 일정하게 세 집단으로 나뉘는 모습을 보였다. 또한 집단들의 지표 변수를 비교하였을 때, 각 시기에서 저, 중, 고 집단의 지표 변수별 평균은 모두 저, 중, 고 집단의 순으로 증가하는 것을 확인하였다. 3개의 잠재프로파일이 저, 중, 고로 분류되어 연속적인 삶의 만족도 수준을 단순히 크기에 따라 요약했다고 생각할 수 있으나, 삶의 만족도의 여러 지표에서 사람들의 이질적인 특성이 존재하지 않았다면 1개의 프로파일이 적합했을 것이다. 분류된 잠재프로파일의 형태가

집단 간 교차 지점 없이 모든 영역에서 일관되게 저, 중, 고의 순서를 보인 것은 본 연구에서 활용한 지표변수들이 삶의 만족도가 갖는 인지적 영역을 적절하게 대표함을 의미한다. 이외에도 두 시기의 집단 분류 양상 및 각 집단의 구성 비율은 매우 유사하게 나타났으며, 측정동일성 검증 결과에서도 두 시기의 잠재 프로파일 분류 결과를 동일하게 해석할 수 있음이 확인되었다. 이러한 결과는 1차 및 2차 연도의 비교에서 개개인의 집단 간 이동은 있을지라도, 시기와 무관하게 삶의 만족도 집단이 갖는 전반적인 분류 양상은 유지되고 있었음을 보여준다.

본 연구에서 도출된 삶의 만족도 잠재프로파일을 세부적으로 살펴보면, 지표변수들이 모두 비슷한 수준으로 나타나는 상 집단과 비교하여 저, 중 집단은 경제 상태나 건강 상태 만족도가 관계 만족도에 비해 떨어지는 경향이 있었다. 이는 이전부터 관찰되어온 노년기 삶의 만족도의 특징으로, 진기남과 이규식(2000)에서도 노년층의 경제, 건강에 대한 만족도의 개인 편차가 관계 만족도에 비해 크게 나타난 바 있다. 정명숙(2005)의 연구에서도, 성인 및 청소년 집단에서의 신체 및 물질 만족도와 사회관계 만족도 간 평균 점수 차에 비해 노인 집단의 평균 점수 차이가 더 크게 나타났다. 이러한 고령층 삶의 만족도의 특징은 생애 주기상 중고령기에서 경제 능력 및 건강의 저하가 불가역성을 띄어 한 번 상실되면 돌이키기 어려운 반면, 가족과의 관계라는 자원은 반드시 연령의 증가에 따라 감소하지 않으므로(노유지, 이해경, 이원형, 조정래, 2018) 최초 상실 이후 회복되지 못한 경제 및 건강 관련 지표변수의 편차가 드러난 것일 수 있다. 달리 해석하면, 물질 및 건강과 달리 고령층의 전 생애에 걸쳐 형성된 강한 회복탄력성과 빠른 적응 능력은 고령층 전반에 유효하기에(이서연, 장미나, 2022; Foster, 1997), 코로나19 중 가족이나 친척과의 왕래가 상대적으로 활발해진 환경(남승연, 이영범, 2023) 속에서도 관계 만족도를 유지하는 능력은 저, 중 집단에서도 크게 저하되지 않았던 것이라고 볼 수 있다.

다음으로, 잠재 프로파일의 분류에 영향을 미치는 요인에서 가구 총자산, 일상생활 도움 필요 정도, 우울이 시기별 모든 집단 간 비교에서 유의한 영향변수로 나타났다. 이는 경제적으로 안정될수록 삶의 만족도가 높고, 신체적 기능이 저하되거나 부정적 정서를 많이 경험할수록 삶의 만족도가 낮게 나타날 가능성이 큰 것으로 해석할 수 있다. 해당 경제, 건강 변수들의 경우 이전의 많은 연구에서도 삶의 만족도에 미치는 유의한 영향이 보고되었고(강이주, 2008; 박상규, 2006; 박순미, 2011), 본 연구에서도 이를 재확인하였다. 특히 그중에서도 심리적 건강과 같이 외부적 지원을 통하여 변화를 가져올 수 있는 변수들이 유의한 결과를 보였다는 것은, 노년층의 우울감 극복을 위한 적극적 정책 지원이 삶의 만족도를 개선할 수 있음을 시사한다. 예를 들어, 거동이 불편해져 사회적 활동이 줄어들고 고립감에 노출되기 쉬운 노년층의 우울감 문제에 대응하고, 그들의 사회 참여를 늘리기 위한 돌봄 프로그램 서비스 개선(이석환, 전용호, 2022)이 이루어진다면 삶의 만족도 제고에 도움이 될 수 있을 것이다. 친목 모임 참여 또한 2차 연도 중-저 집단 간의 비교를 제외하면 모두 유의한 영향변수로 나타나며, 꾸준한 영향력을 보여주었다. 친목 모임은 2020년의 행사 및 모임 참석 자제, 신체접촉 금지 및 2m 거리두기와 같은 방역 수칙으로(중앙재난안전대책본부, 2020) 상당수의 외부 활동이 제한을 받은 상황과, 이에 대비되는 사회적 거리두기 조치의 전면 해제(보건복지부, 2022) 이후에도 대부분의 비교에서 영향력을 유지하며 그 중요도를 확인할 수 있었다.

한편, 학력, 노동, 운동의 경우 일부 집단 비교에서만 영향력을 보였다. 우선 학력의 경우 1차 연도에서는 고 집단과 저 집단의 비교에 있어 유의한 영향변수에 포함되었으나, 2차 연도에서는 모두 유의하지 않았다. 이는 저학력층이 코로나19가 급속히 확산되던 1차 연도에 경제적 타격을 크게 입었기 때문일 수 있는데, 저학력층이 위기 상황에서 고용 감소나 실업과 같은 경제적 어려움을 가장 크게 체감한 집단이었음은 이를 뒷받침한다(남궁은하, 2021; Cortes & Forsythe, 2020). 이는 저학력층이 경제적 어려움뿐만 아니라, 정보 접근성이나 사회적 자원의 제한으로 사회적 거리두기 등 코로나 초기 강건한 감염병 예방 정책들에 있어 위기 대응 능력이 낮았음을 보여주는 대목이다. 노동의 경우에도 1차 연도에서만 고 집단과 저 집단의 비교에 있어 유의한 결과를 보였는데, 이러한 결과 또한 코로나19 시기에 사회적, 경제적 자원을 확보할 수 있는 경로가 양질의 삶을 유지하는 데 있어 결정적인

영향을 미쳤음을 시사한다. 운동의 경우, 1차 연도에는 유의한 영향력을 보이지 못하였으나 2차 연도에서는 운동에 참여할수록 저 집단보다 고 집단에 속할 확률이 높게 나타났다. 고령자들은 주로 노인복지회관이나 경로당, 복합시설 등에서 운동 프로그램에 참여하는 경우가 많고, 이들이 운동에 참여하는 동인은 청년층에 비해 타인과의 소통과 교류를 위한 성격이 강하다고 알려져 있다(김석일, 오현옥, 2016; 김성덕, 2021). 코로나가 한창 유행하던 1차 연도에는 백신패스와 같은 방역 수칙 시행에 따라 모든 스포츠 활동이 공간이나 인원 측면에서 제한적으로 이루어졌던 만큼(권기남, 서금란, 박성혜, 2024; 권오정, 2020), 노년층의 삶의 만족도 잠재 계층을 막론하고 운동 참여가 원활하지 못해 일종의 사회적 활동으로서 운동의 긍정적 효과를 체감하기 어려웠을 것이다. 하지만 2차 연도의 경우 방역 정책이 완화된 후, 관계성을 충족할 수 있는 활동의 창구로서 운동 공간(전상완, 신종섭, 김알찬, 2021)도 재확보되며 운동 참여가 신체 및 심리적 건강에 미치는 긍정적 영향력을 회복했을 가능성이 있다.

1차에서 2차 연도로의 시점 변화에 따라 집단별 전이확률을 확인한 결과, 삶의 만족도 고 집단(73.7%)은 저 집단(44.4%)과 중 집단(65.1%)에 비해 집단의 이동이 적고 높은 삶의 만족도를 유지하는 비중이 높게 나타났다. 이는 삶의 만족도가 높을수록 노년기의 다양한 변화에 대처하는 심리적 자원이 증가한다는 연구 결과(김수경, 이현주, 최은영, 신혜리, 김영선, 2021)와 같이, 삶의 만족도 고 집단이 자신의 삶에서 느끼는 다양한 심리 및 경제적 만족을 바탕으로 안정성을 유지하였을 가능성을 보여준다. 또한, 1차 연도에서 중 집단의 이동에서는 저 집단으로 이동하는 비율(13.2%)보다 고 집단으로 이동할 비율(21.7%)이 높게 나타났다. 1차 연도의 저 집단도 2차 연도 중 집단으로의 높은 이동 비율(47.0%)을 보였다. 코로나19 시기 고령자의 삶의 만족도에 대한 일부 연구에 따르면, 회복탄력성에 기반한 빠른 적응력 등 심리적 자원과 더불어 건강에 대한 관심 증대, 가족과의 유대감 증가 등 팬데믹 이후 나타난 긍정적 측면으로 인해 고령층에게 가해지는 부정적 영향이 완화되었을 수 있다(Ausin et al., 2022; Center for Ageing Better, 2020). 본 연구에서의 결과 또한 고령층이 보유한 자원이 보호요인으로 기능한 결과로 볼 수 있다. 다른 한편으로, 이는 노인의 삶의 만족도가 코로나와 관련한 정책적 제한들이 완화되며 일시적으로 삶의 만족도 수준이 반등하였을 가능성을 보여준다. 실제로 이태진, 우선희, 김지원(2023)의 연구에서도 2019년에 비해 2021년의 삶의 만족도가 모든 인구층에서 감소하였다가, 2022년에 접어들자 2019년의 삶의 만족도 수준 이상으로 회복세를 보이는 모습을 보여주었다.

전이 영향요인을 분석한 결과에서는, 집단의 전이에 유의한 영향을 미치는 유일한 변수로서 친목모임 참여의 중요성을 확인할 수 있었다. 사회적 활동에 많이 참여할수록 1차 연도의 삶의 만족도 저 집단은 고 집단으로 이동할 가능성이 높게 나타났고, 중 집단은 저 집단 대신 자신의 집단을 유지할 확률이 높게 나타났다. 이는 사회관계 형성이 고령자의 삶의 질 유지 및 개선에 기여했음을 의미한다. 잠재프로파일 분류에서는 경제 요인, 건강 요인, 사회관계 요인이 모두 유의한 영향 요인이었음에도 전이 영향 요인에서는 사회관계 요인만 유의했던 것은, 경제 또는 건강 요인에 비해 외부 제한의 완화에 따라 상대적으로 회복이 쉬운 특성 때문일 가능성이 있다. 또한, 본 연구 결과는 코로나19와 같이 사회관계 형성이 단절된 상황에서 사회적 활동에의 참여가 고령자의 삶의 질을 크게 좌우할 수 있음을 보여준다. 이는 일자리 사업을 통한 지속적 사회 참여가 노년층의 신체적 건강 증진 및 심리적 안정을 위한 보호 요인으로 작용하였다(배고은, 2022)는 연구와 맥을 같이하며, 청년층이 동일 시기에 경제적 취약성 및 현실적 생활만족도에 가장 큰 영향을 받은 것(조은희, 홍상욱, 2023)과 대조되는 흥미로운 결과이다. 이러한 결과를 바탕으로, 고령자가 주변 환경과 원만한 교류 및 사회관계를 유지할 수 있도록 돕는 사회 참여 증진 정책이 심도 있게 논의되어야 할 것이다. 특히 사회 참여 증진 정책은 장기적 관점에서 그 역할이 두드러지는데, 이는 한국 사회의 고령화 및 독거노인의 증가를 고려하였을 때 단순히 고령층의 삶의 만족도를 향상하는 것 이상의 효과를 가져올 수 있기 때문이다. 실제로 독거노인들은 사회적 관계망의 부재와 관계 약화를 가장 큰 어려움으로 꼽고 있고(정경희, 2015), 사회적 지지가 늘어날수록 고독사에 대한 걱정도 줄어든다는 점이 선행연구에서 밝혀진 바 있다(조혜진, 이준영, 2020). 그러므로 노년기의 사회적 관계에 집중한 정책은 고독사나 지역사회 돌봄과 같은

향후 고령화 사회의 다양한 사회적 문제 대응에도 도움이 될 것이다.

본 연구는 다음과 같은 제한점이 있다. 우선, 본 연구에서는 2020년 하반기에 수집된 자료와 2022년 하반기에 수집된 자료를 활용하여, 2023년 이후의 전이 양상은 분석에 포함하지 못하였다. 본 연구의 자료 수집 시기는 코로나 19가 가장 많이 창궐하였던 시기(1차 연도) 및 그 영향력이 아직 잔존하던 시기(2차 연도)로, 본 연구의 프로파일 및 전이 양상도 이에 영향을 받았을 수 있다. 그러므로 코로나19의 영향력이 미미해지는 2023년 이후의 자료를 포함하여 최소 3시점 이상의 자료를 활용한다면 엔데믹 이후의 노인의 삶의 만족도 변화 양상을 살펴볼 수 있을 것이다. 이를 통해 노인의 삶의 만족도 수준 전이 양상을 장기적으로 확인한다면 프로파일 변화에 영향을 미치는 더욱 다양한 요인이 드러날 수 있을 것이다. 다음으로, 본 연구에서 지표변수들의 평균이 1차 연도 대비 2차 연도에 더 높게 나타난 것은 고령층을 대상으로 한 패널 데이터에서 발생한 선택 편향(Selection Bias)의 영향일 수 있다. 본 연구의 2차 연도 탈락 표본의 나이 및 건강 상태에 대한 응답으로 미루어 보아 건강 악화 및 사망 등이 주 탈락 이유일 것으로 추정되므로, 해석에 주의가 필요하다. 마지막으로, 본 연구에서는 데이터의 부재에 따라 디지털 환경 적응 요인이 고령층의 삶의 만족도에 미치는 영향력을 확인하지 못했다. 본 연구에서 사용한 데이터 수집이 이루어진 시기에는 감염병을 막기 위한 사회적 거리두기 정책으로 소비 및 사교활동의 비대면화가 일상화되었다. 실제로 디지털 생활서비스 활용에서 청년층과 노년층의 격차는 상당히 크게 나타나고 있으며(박선주, 김성준, 고정현, 권유진, 2020) 해당 시기 디지털 전환에 따른 일상 변화 만족도가 노년층에서 가장 낮았던 점을 고려한다면(오주현, 2024), 디지털 환경 적응 요인이 고령층의 삶의 만족도에 미치는 영향은 상당할 것으로 예상된다. 따라서 추후 디지털 환경 적응 요인을 포함하여 연구를 진행한다면, 조사 시기의 특성을 더욱 풍부하게 반영할 수 있을 것으로 보인다.

위와 같은 한계점에도 불구하고, 본 연구에서는 이전에는 결과 변수로 주로 활용되었던 삶의 만족도 변수에 초점을 두어 삶의 만족도에 따른 계층 분류를 새롭게 시도하였다. 선행연구에서는 노년기 전반적인 삶의 만족도에 대한 잠재프로파일 분류는 이루어지지 않았고, 노년기에 영향을 미칠 수 있는 경제, 환경 요인 등을 잠재프로파일로 분류한 뒤 결과 변수로만 삶의 만족도를 활용하는 경우가 많았다(부혜인 외, 2023; 오유라, 2023). 하지만 본 연구에서는 삶의 만족도 프로파일의 영역별 평균이 교차 지점 없이 나타나는 것을 확인하며, 이질적 집단 간 특성을 반영하여 삶의 만족도 프로파일을 분류하더라도 그 수준이 저, 중, 고로 일정하게 유지됨을 검증했다. 또한, 본 연구는 노년층의 삶의 만족도 전이 양상을 확인하여 종단적인 변화를 관찰하였다는 의의가 있다. 이전의 연구에서도 노년층의 삶의 만족도에 대한 종단적 연구는 많이 이루어져 왔으나, 단일 종속변수로 설정된 삶의 만족도 궤적의 발달 형태에 주목하는 형태였다(허원구, 2017; 홍성애, 이수재, 김혜진, 윤숙현, 2024). 본 연구에서는 삶의 만족도의 다양한 영역을 반영하여 개인이 시간이 지남에 따라 최초 소속되었던 유형의 집단에서 질적으로 구분되는 다른 수준의 집단으로 이동할 가능성에 주목하였고, 삶의 만족도 상위 집단일수록 자신의 삶의 만족도에 대한 평가 수준을 높은 수준으로 유지하는 양상을 밝혔다. 마지막으로, 본 연구는 노년층의 삶의 만족도에 있어 사회적 관계가 갖는 중요성을 확인하였다. 이전에도 여가, 종교, 친목 활동 참여 등 다양한 사회관계가 노년층의 삶에 미치는 영향을 살펴본 연구들은 존재하였으나(김지희, 박종, 2021; 이보미, 2016), 사회활동이 원활하지 않은 환경에서도 이러한 요소들이 고령자의 삶의 만족도에 가져올 영향력을 종단적으로 검증한 연구는 제한적이었다. 이에 본 연구는 코로나 19라는 특수한 배경에서 시간의 흐름을 반영하여 사회관계의 영향력을 더욱 구체적으로 확인하였다는 의의가 있다. 이상의 의의를 바탕으로 앞으로도 노년층의 안정적 삶의 만족도를 구축하기 위한 정책이 더욱 풍성하게 이어지길 기대한다.

참고문헌

- 강소랑, 문상호. (2011). 중, 고령자의 삶의 질에 관한 증험적 (Evidence-Based) 정책설계 - 고령화연구패널 (KLoSA) 자료를 이용한 실증분석. **한국정책학회보**, 20(2), 353-382.
- 강이주. (2008). 노인의 삶의 질 관련요인 분석. **가정과삶의질연구**, 26(5), 129-142.
- 강희순, 김지인. (2022). 농촌 후기노인의 건강관련 삶의 질 영향요인. **인문사회** 21, 13(6), 3295-3310. doi.org/10.22143/HSS21.13.6.227
- 고영근, 안태현. (2023). 코로나19와 생활만족도: 비인지적 특성의 역할. **경제학연구**, 71(1), 75-115. doi.org/10.22841/kjes.2023.71.1.003
- 고혜진, 정해식. (2022). 중고령자의 삶의 만족도 결정요인에 대한 연구. **노인복지연구**, 77(1), 311-334. doi.org/10.21194/kjgsw.77.1.202203.311
- 권기남, 서금란, 박성혜. (2024). COVID-19 상황에서 노인운동참여의 문제점과 대안에 관한 연구. **한국스포츠사회학회지**, 37(3), 21-39. doi.org/10.22173/ksss.2024.37.3.2
- 권오정. (2020). 코로나19에 의한 노인 운동행동 변화 사례 연구. **한국스포츠심리학회지**, 31(2), 123-134. doi.org/10.14385/KSSP.31.2.123
- 김경래, 황남희, 진화영, 유재언. (2020). **초고령사회 노인의 다양성과 사회정책적 대응** (연구보고서 2020-45). 세종: 한국보건사회연구원.
- 김동배. (2008). 한국 노인의 성공적 노화 척도 개발을 위한 연구. **한국사회복지학**, 60(1), 211-231. doi.org/10.20970/kasw.2008.60.1.009
- 김미령. (2012). 연령과 성별에 따른 노인의 삶의 질 영향요인 차이분석. **한국노년학**, 32(1), 145-161.
- 김미숙, 원종욱, 서문희, 강병구, 김교성, 임유경. (2003). **고령화사회의 사회경제적 문제와 정책대응방안: OECD 국가의 경험을 중심으로** (연구보고서 2003-14). 세종: 한국보건사회연구원.
- 김미혜, 문정화, 성기옥. (2014). 성인의 생애주기별 주관적 행복감과 영향요인에 관한 연구: Alderfer의 ERG 이론 적용. **한국노년학**, 34(4), 857-875.
- 김석일, 오현옥. (2016). 신체활동에 참여하는 노인들의 자기효능감, 자아통합감 및 성공적 노화. **한국체육학회지**, 55(6), 509-520.
- 김성덕. (2021). 코로나19와 노인의 스포츠 참여 어려움과 대응방안: 게이트볼 동호인 중심으로. **한국체육정책학회지**, 19(3), 145-158.
- 김성아, 정해식. (2019). 연령대별 삶의 만족 영향요인 분석과 정책 과제. **보건복지포럼**, 270, 95-104. doi.org/10.23062/2019.04.9
- 김수경, 이현주, 최은영, 신혜리, 김영선. (2021). 한국 노인의 회복탄력성 예측요인 분석. **노인복지연구**, 76(2), 35-59. doi.org/10.21194/kjgsw.76.2.202106.35
- 김은경. (2017). 노인의 연령계층별 건강관련 삶의 질 관련요인. **Journal of the Korean Data Analysis Society**, 19(5), 2807-2823. doi.org/10.37727/jkdas.2017.19.5.2807
- 김은하, 이지원. (2009). 복지관 이용 노인의 건강관련 삶의 질 영향요인: 일상생활 수행능력, 수면의 질 및 우울을 중심으로. **한국노년학회지**, 29(2), 425-440.
- 김지희, 박종. (2021). 노인의 사회적 자본이 건강 관련 삶의 질에 미치는 영향 -2019년 지역사회건강조사를 중심으로-. **농촌의학·지역보건학회지**, 46(4), 280-294. doi.org/10.5393/jamch.2021.46.4.280
- 김진원, 임구원. (2019). 노인의 친교활동, 주관적 건강상태, 우울감의 관계에 대한 다변량 잠재성장모형 분석. **한국여가**

- 레크리에이션학회지, 43(4), 1-15. doi.org/10.26446/kjlrp.2019.12.43.4.1
- 김창환. (2015). 중고령자의 사회경제적 특성, 노동시장 참여형태가 삶의 만족도와와의 관련성. **보건의료생명과학논문지**, 3(1), 79-88.
- 김학주. (2017). 노인가구의 경제적 변인이 생활만족도에 미치는 영향에 관한 연구: 건강변수의 조절효과를 중심으로. **생명연구**, 46, 297-349.
- 김혜연. (2020). 성별 및 연령 집단별 주관적 삶의 질 (subjective well-being)의 원인에 대한 연구. **한국정책과학학회보**, 24(2), 47-72. doi.org/10.31553/kpsr.2020.6.24.2.47
- 남궁은하. (2021). 코로나19로 인한 노인생활의 변화와 정책 과제. **보건복지포럼**, 300, 72-85. doi.org/10.23062/2021.10.7
- 남상권, 심옥수. (2011). 만성질환노인의 삶의 질 영향요인 연구 : 만성질환유형을 중심으로. **노인복지연구**, 53, 196-221. doi.org/10.21194/kjgsw..53.201109.196
- 남승연, 이영범. (2023). 코로나 전후 사회적 관계가 삶의 만족도에 미치는 영향에 관한 연구. **정책분석평가학회보**, 33(3), 1-25. doi.org/10.23036/kapae.2023.33.3.1
- 노유지, 이해경, 이원형, 조정래. (2018). 경제, 건강, 관계자원과 다차원적 삶의 만족: 중고령인구 패널자료를 중심으로. **행정논총**, 56(3), 233-267.
- 문준호, 송명근, 이원석, 당약함. (2021). 고령화 패널 자료를 이용한 노인 삶의 질의 결정요인. **공공정책연구**, 38(1), 233-254. doi.org/10.33471/ILA.38.1.10
- 박상규. (2006). 노인의 정신건강과 삶의 질 간의 관계. **한국심리학회지: 건강**, 11(4), 785-796.
- 박선숙. (2018). 노인의 삶의 만족도 결정요인에 관한 연구: 의사결정트리모형을 이용하여. **사회과학연구**, 29(3), 39-57. doi.org/10.16881/jss.2018.07.29.3.39
- 박선주, 김성준, 고정현, 권유진 (2020). 디지털 정보활용 유형이 세대별 삶의 만족도에 미치는 영향. **한국공공관리학보**, 34(3), 49-81. doi.org/10.24210/kapm.2020.34.3.003
- 박순미. (2011). 노인의 건강상태가 삶의 만족도에 미치는 영향. **노인복지연구**, 53, 305-332. doi.org/10.21194/kjgsw..53.201109.291
- 반상진, 임효진, 조영재, 이진권. (2015). 교육투자 결과로서 학력수준이 삶의 질에 미치는 효과 -고용과 건강, 사회관계의 매개효과-. **교육재정경제연구**, 24(2), 111-131.
- 배고은. (2022). 코로나19의 장기화가 노인의 일상생활에 미치는 영향에 대한 탐색적 연구: 노인복지관 이용자를 중심으로. **한국웰니스학회지**, 17(1), 1-13. doi.org/10.21097/ksw.2022.2.17.1.1
- 배다영, 박은빈. (2022). 1인가구 중고령자의 일상생활수행능력(ADL/IADL) 및 우울감의 변화궤적과 삶의 만족도: 병렬과정 잠재성장모형의 적용. **가정과삶의질연구**, 40(1), 11-25. doi.org/10.7466/JFBL.2022.40.1.11
- 배성우, 김이영, 도문학, 김혜지, 박병선. (2020). 축약형 우울척도 (CES-D-10)의 요인구조 및 측정불변성 검증: Andersen form과 Boston form을 중심으로. **정신건강과 사회복지**, 48(1), 33-55. doi.org/10.24301/MHSW.2020.03.48.1.33
- 보건복지부. (2022). 사회적 거리두기 조치 약 2년 1개월만에 해제 손씻기, 환기·소독 등 일상 속 감염 차단을 위한 생활방역 수칙 준수 더욱 중요. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&tag=&act=view&list_no=371078&cg_code=
- 부혜인, 송종환, 최윤경, 이재호, 이홍석, 이홍표. (2023). 베이비붐 세대의 성공적인 노화와 삶의 질. **한국위기관리논집**, 19(7), 153-182. doi.org/10.14251/crisisonomy.2023.19.7.153
- 서경숙, 김재태. (2023). 중고령자의 인구·사회·경제 특성별 삶의 질 차이 분석. **주거환경**, 21(1), 1-20.

- 서순림, 김미한. (2014). 독거노인 건강관련 삶의 질의 영향 요인. **한국노년학**, 34(4), 705-716.
- 서예린, 박자경, 고귀영. (2021). 랜덤 포레스트를 활용한 고령자의 삶의 만족도 영향요인 탐색. **한국노년학**, 41(5), 803-823. doi.org/10.31888/JKGS.2021.41.5.803
- 석재은, 장은진. (2016). 여성독거노인과 남성독거노인의 관계자원이 삶의 만족도에 미치는 영향. **노인복지연구**, 71(2), 321-349. doi.org/10.21194/kjgsw.71.2.201606.321
- 성기옥, 김수진, 문정화. (2021). 코로나19로 인한 생활변화가 노인의 우울에 미치는 영향. **사회복지 실천과 연구**, 18(2), 99-129. doi.org/10.38082/SWPR.2021.18.02.99
- 손누리, 김구나, 서영준. (2022). 중·고령자의 건강관련 삶의 질 관련요인. **대한보건연구**, 48(2), 19-32. doi.org/10.22900/kphr.2022.48.2.002
- 손주희, 이명진. (2018). 노인의 경제적 지위와 주관적 삶의 질의 관계에서 사회적 지지의 간접효과에 관한 연구. **사회과학 연구논총**, 34(1), 43-71. doi.org/10.16935/ejss.2018.34.1.003
- 송시영, 전해정, 최봄이. (2020). 노년기 경제활동이 우울감과 삶의 만족도에 미치는 영향 : 성향점수매칭(PSM)과 이중차이(DD) 분석. **한국노년학**, 40(5), 895-911. doi.org/10.31888/JKGS.2020.40.5.895
- 안찬우, 이원미. (2021). 노인의 운동참여 정도에 따른 운동효과 및 건강과 체력인식의 차이. **한국특수체육학회지**, 29(2), 245-254.
- 양성찬, 장진화, 박신영, 안선희, 김성순, 박수빈, . . . 권동혁. (2022). 국내 코로나19 확진자 2년 발생 보고서. **주간 건강과 질병**, 15(7), 414-426.
- 여유진. (2022). **코로나19 발생 전후 삶의 만족도와 사회통합 인식의 변화** (보건복지 Issue & Focus 제418호). 세종: 한국보건사회연구원. doi.org/10.23064/2022.02.418
- 연병길, 서국희, 류성곤, 임종우, 방현숙, 신지용, 한창환. (1999). 정상 노인 및 노인 치매 환자와 우울증 환자의 삶의 질 비교. **노인정신의학**, 3(2), 157-164.
- 오유라. (2023). 노인의 지역사회환경 만족 유형별 삶의 만족도·차별경험 차이에 관한 연구. **사회과학논집**, 54(1), 21-39. doi.org/10.31502/SSRI.54.1.2
- 오종석, 손세호, 안상화. (2023). 코로나19 시기 노인가구의 우울감과 삶의 만족도 변화 분석: 독거노인과 노인부부가구의 차등적 변화를 중심으로. **도시연구**, 23, 215-262. doi.org/10.34165/urbanr.2023..23.215
- 오주현. (2024). 코로나19 이후 디지털 전환 가속화에 따른 연령 집단별 일상변화 만족도: 디지털 역량과 인터넷 서비스 이용량 변화를 중심으로. **한국노년학**, 44(4), 493-507. doi.org/10.31888/JKGS.2024.44.4.493
- 오창석. (2012). 노인의 주관적 건강 인식과 삶의 질이 우울과 자살 생각에 미치는 영향. **보건의료산업학회지**, 6(2), 179-191.
- 왕연연, 허만세, 김영숙. (2022). 노인의 건강 상태가 삶의 만족도 변화에 미치는 영향. **보건사회연구**, 42(3), 351-368. doi.org/10.15709/hsr.2022.42.3.351
- 유재남. (2016). 고령자의 활동적 노화가 삶의 만족도에 미치는 영향요인. **한국노년학**, 36(4), 1075-1088.
- 이경옥. (2008). 서울시 노인의 삶의 질에 대한 탐색적 연구. **노인복지연구**, 42, 55-77. doi.org/10.21194/kjgsw..42.200812.55
- 이미숙. (2010). 도시거주 노인의 만성질환과 우울증세의 상관성 및 사회관계망의 효과에 대한 연구. **보건과 사회과학**, 27, 5-30.
- 이보미. (2016). 노년의 삶에 의미를 부여하는 여가역할에 관한 질적 연구 - 거주지역의 배드민턴 활동 참여자 중심으로. **관광학연구**, 40(8), 99-115. doi.org/10.17086/JTS.2016.40.8.99.115
- 이서연, 장미나. (2022). 코로나19 팬데믹에 따른 노년층의 일상생활 변화와 삶의 질: 1인 가구와 다인 가구 비교를

- 중심으로. *Family and Environment Research*, 60(2), 163-176. doi.org/10.6115/fer.2022.011
- 이석환, 전용호. (2022). 코로나19 시기 노인의 우울감은 일상생활수행능력과 삶의 만족도 관계에 영향을 미쳤는가?: 독거노인과 비독거노인 비교를 중심으로. *노인복지연구*, 77(4), 91-115. doi.org/10.21194/kjgsw.77.4.202212.91
- 이윤표, 박수근, 길재호, 맹성호, 신정원, 정샘. (2018). 노인의 운동참여 정도에 따른 주관적 건강상태와 우울 및 삶의 만족도 간의 관계. *한국발육발달학회지*, 26(4), 495-500. doi.org/10.34284/KJGD.2018.11.26.4.495
- 이태진, 우선희, 김지원. (2023). 코로나19 전후 삶의 만족도와 사회통합 인식 변화. *보건복지포럼*, 323, 6-21. doi.org/10.23062/2023.09.2
- 이형석, 김지혜, 김도관, 고혜정, 구형모, 권의정. (2003). 「노인삶의질척도(Geriatric Quality of Life scale)」의 표준화. *한국심리학회지: 임상*, 22(4), 859-881.
- 임영아, 조영채. (2017). 요양시설 노인의 사회적지지, 신체적 및 정신적 건강수준이 삶의 질에 미치는 영향에 대한 공분산구조분석. *한국산학기술학회논문지*, 18(8), 210-220. doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.8.210
- 전상완, 신종섭, 김알찬. (2021). 팬데믹시대, 노인운동의 사회적 의미와 정보 고찰. *한국스포츠학회지*, 19(4), 249-260. doi.org/10.46669/kss.2021.19.4.023
- 전은영, 최연희. (2010). 취약계층 남성노인의 연령별 건강관련 삶의 질과 영향요인. *대한간호학회지*, 40(3), 400-410.
- 정경희. (2012). *한국노인의 생활실태와 의식 -「2011년 노인실태조사」의 주요 결과를 중심으로-* (보건복지 Issue & Focus 제147호). 세종: 한국보건사회연구원. doi.org/10.23064/2012.07.147
- 정경희. (2015). *노년기 독거 현황과 정책적 대응 전략* (보건복지 Issue & Focus 제300호). 세종: 한국보건사회연구원.
- 정명숙. (2005). 연령과 삶에 대한 만족도. *한국심리학회지: 발달*, 18(4), 87-108.
- 정영해, 조유향. (2014). 한국 전·후기 노인의 삶의 질 관련요인과 성별 차이. *농촌의학·지역보건학회지*, 39(3), 176-186. doi.org/10.5393/JAMCH.2014.39.3.176
- 정운영, 정세은. (2011). 1인 노인가구의 경제적 특성과 삶의 만족도 연구: 저소득가구와 고소득 가구의 비교. *한국노년학*, 31(4), 1119-1134.
- 조동훈. (2015). 중고령자 삶의 만족도 결정요인 패널분석. *응용경제*, 17(1), 5-27.
- 조은희, 홍상욱. (2023). 코로나 19 사회적 거리두기가 세대별 주관적 삶의 만족도에 미치는 영향요인에 관한 비교 연구. *한국지방자치연구*, 25(1), 49-72.
- 조혜진, 이준영. (2020). 독거노인의 자각된 사회적 지지와 시설 돌봄 선호: 고독사 가능성 인식의 매개 효과 분석. *한국노년학*, 40(4), 707-727. doi.org/10.31888/JKGS.2020.40.4.707
- 중앙재난안전대책본부. (2020). *코로나바이러스감염증-19 중앙재난안전대책본부 정례브리핑(11.1.일)*. https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156418582
- 진기남, 이규식. (2000). 노인의 삶의 영역별 만족도와 삶의 질. *보건과 사회과학*, 8(1), 35-53.
- 질병관리청. (2023). [5.11. 목. 정례브리핑 보도자료] *코로나19 위기상황에서 벗어나 일상회복 추진*. https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20501000000&bid=0015&list_no=722503&cg_code=&act=view&nPage=3&new sField=202305
- 차은진, 김경호. (2015). 중·고령자의 주관적 건강상태가 삶의 만족도에 미치는 영향: 우울의 매개효과 검증. *노인복지연구*, 70, 54-81. doi.org/10.21194/kjgsw..70.201512.53
- 채중훈, 서정원. (2019). 고령자 삶의 만족도에 미치는 영향요인에 관한 연구: 도·농간 비교 분석. *한국지역개발학회지*, 31(3), 137-158.
- 최미영, 곽현근, 박현식. (2014). 노인의 주관적 삶의 질에 미치는 지역사회 사회자본의 영향: 노인 우울감의 매개효과를 중심으로. *노인복지연구*, 66, 307-328. doi.org/10.21194/kjgsw..66.201412.307

- 최아영, 윤현숙. (2012). 고령자의 경제활동 참여여부와 참여이유가 심리적 안녕에 미치는 영향. *미래사회복지연구*, 3(1), 5-31.
- 최혜진. (2023). 코로나19 전후 유럽과 한국 노인의 고용, 관계, 정신건강 변화. *국제사회보장리뷰*, 27, 53-64. doi.org/10.23063/2023.12.5
- 최효진, 이흥직. (2019). 노인의 삶의 질에 영향을 미치는 요인에 관한 연구: 인구사회학적 요인, 환경적 요인, 제도적 요인을 중심으로. *한국웰니스학회지*, 14(1), 103-112. doi.org/10.21097/ksw.2019.02.14.1.103
- 통계청. (2023a). **2023 고령자 통계**. 대전: 통계청.
- 통계청. (2023b). **2022년 생명표**. 대전: 통계청.
- 하진호, 이지연, 최소영, 박숙경. (2023). 수도권 코로나19 발생 현황가 특성. *주간 건강과 질병*, 16(5), 111-136.
- 한국고용정보원. (2024). **고령화연구패널조사 8-9차**. <https://survey.keis.or.kr/klosa/klosadownload/List.jsp> (2024/03/23).
- 한국보건사회연구원. (2023). **2023년 빈곤통계 연보**. 세종: 한국보건사회연구원.
- 한국행정연구원. (2023). **사회통합실태조사: 삶에 대한 만족도**. 국가통계포털 KOSIS. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=417&tblId=DT_417001_0002&conn_path=I2
- 한준. (2020). 한국의 생애과정과 주관적 웰빙. 이재열(편), *한국의 사회동향 2020* (pp. 376-384). 대전: 통계개발원.
- 한형수. (2008). 노인의 삶의 질의 객관적 지표와 주관적 만족도에 관한 연구. *노인복지연구*, 39, 347-372. doi.org/10.21194/kjgsw..39.200803.345
- 허원구. (2017). 노인의 삶의 만족도 발달궤적과 건강특성요인. *사회복지정책*, 44(2), 297-318. doi.org/10.15855/swp.2017.44.2.297
- 허준수, 유수현. (2002). 노인의 우울에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. *정신보건과 사회사업*, 13, 7-22.
- 현은민. (2020). 고령사회 노인의 활동적 노화가 삶의 만족도에 미치는 영향. *인문사회* 21, 11(4), 1491-1506.
- 홍성애, 이수재, 김혜진, 윤숙현 (2024). 고령자의 삶의 만족도와 주관적 계층의식이 인지기능에 미치는 영향의 종단연구. *대한보건연구*, 50(3), 27-36. doi.org/10.22900/kphr.2024.50.3.003
- 홍주연. (2018). 성별에 따른 65세 이상 노인의 삶의 질에 관한 연구. *한국콘텐츠학회논문지*, 18(8), 616-626. doi.org/10.5392/JKCA.2018.18.08.616
- 황미구. (2008). 재가 여성노인의 우울, 체질량 및 인지기능이 주관적인 삶의 질에 미치는 영향: IADL 및 ADL을 매개변인으로 하여. *노인복지연구*, 42, 407-430. doi.org/10.21194/kjgsw..42.200812.407
- 황미구, 김은주. (2008). 노인의 우울과 인지능력이 건강 관련 삶의 질에 미치는 영향: 자살생각을 매개변인으로 하여. *노인복지연구*, 41, 385-404. doi.org/10.21194/kjgsw..41.200809.385
- 황여정, 김수혜. (2010). 빈곤이 주관적 삶의 질에 미치는 영향에 관한 종단 분석. *제3회 한국복지패널 학술대회 논문집*, 547-569.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716-723. doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705
- Andrews, F. M., & Withey, S. B. (1976). *Social indicators of well-being: America's perception of life quality*. New York: Plenum Press.
- Araki, S. (2022). The resilience divide among older adults under uncertainty: A positive sociological study of life satisfaction during the COVID-19 crisis. *Journal of Applied Gerontology*, 41(8), 1792-1801.
- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2014). Auxiliary variables in mixture modeling: Three-step approaches using M plus. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 21(3), 329-341. doi.org/10.1080/10705511.2014.915181

- Ausín, B., González-Sanguino, C., Ángel Castellanos, M., Saiz, J., & Muñoz, M. (2022). Longitudinal study of age-related differences in the psychological impact of confinement as a consequence of COVID-19 in a Spanish sample. *Behavioral Psychology/Psicología Conductual*, 30(1), 93-107. doi.org/10.51668/bp.8322105n
- Barnum, H., Barrett, J., Clark, L. O., Leifer, M., Spekkens, R., Stepanik, N., & Wilke, R. (2010). Entropy and information causality in general probabilistic theories. *New Journal of Physics*, 12(3), 033024. doi.org/10.1088/1367-2630/12/3/033024
- Bergman, L. R., & Magnusson, D. (1997). A person-oriented approach in research on developmental psychopathology. *Development and Psychopathology*, 9(2), 291-319. doi.org/10.1017/s095457949700206x
- Bidzan-Bluma, I., Bidzan, M., Jurek, P., Bidzan, L., Knietzsch, J., Stueck, M., & Bidzan, M. (2020). A polish and german population study of quality of life, well-being, and life satisfaction in older adults during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 585813. doi.org/10.3389/fpsyt.2020.585813
- Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2008). Is well-being U-shaped over the life cycle? *Social Science & Medicine*, 66(8), 1733-1749. doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.01.030
- Bowling, A. (2009). The psychometric properties of the older people's quality of life questionnaire, compared with the CASP-19 and the WHOQOL-OLD. *Current Gerontology and Geriatrics Research*. doi.org/10.1155/2009/298950
- Center for Ageing Better. (2020). *The experience of people approaching later life in lockdown: The impact of COVID-19 on 50-70-year olds in England*. London, UK: Author.
- Cho, J., Martin, P., & Poon, L. W. (2015). Successful aging and subjective well-being among oldest-old adults. *The Gerontologist*, 55(1), 132-143. doi.org/10.1093/geront/gnu074
- Collins, L. M., & Lanza, S. T. (2009). *Latent class and latent transition analysis: With applications in the social, behavioral, and health sciences*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. doi.org/10.1002/9780470567333
- Cortes, G. M., & Forsythe, E. (2020). Heterogeneous labor market impacts of the COVID-19 pandemic. *ILR Review*, 76(1), 30-55. doi.org/10.1177/00197939221076856
- Cummins, R. A. (1996). The domains of life satisfaction: An attempt to order chaos. *Social Indicators Research*, 38, 303-328.
- Cummins, R. A. (2000). Objective and subjective quality of life: An interactive model. *Social Indicators Research*, 52(1), 55-72. doi.org/10.1023/A:1007027822521
- Cutler, N. E. (1979). Age variations in the dimensionality of life satisfaction. *Journal of Gerontology*, 34(4), 573-578. doi.org/10.1093/geronj/34.4.573
- Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542-575. doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542
- Diener, E., & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. *Social Indicators Research*, 40(1-2), 189-216. doi.org/10.1023/A:1006859511756
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276-302. doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276
- Ferguson, S. L., Moore, E. W. G., & Hull, D. M. (2020). Finding latent groups in observed data: A primer on latent profile analysis in Mplus for applied researchers. *International Journal of Behavioral Development*, 44(5), 458-468. doi.org/10.1177/0165025419881721
- Finch, H. (2015). A comparison of statistics for assessing model invariance in latent class analysis. *Open Journal of Statistics*, 5(3), 191-210. doi.org/10.4236/ojs.2015.53022

- Fisher, B. J. (1995). Successful aging, life satisfaction, and generativity in later life. *The International Journal of Aging and Human Development*, 41(3), 239-250. doi.org/10.2190/ha9x-h48d-9gyb-85xw
- Foster, J. R. (1997). Successful coping, adaptation and resilience in the elderly: An interpretation of epidemiologic data. *Psychiatric Quarterly*, 68(3), 189-219. doi.org/10.1023/A:1025432106406
- Frijters, P., & Beaton, T. (2012). The mystery of the U-shaped relationship between happiness and age. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 82(2-3), 525-542. doi.org/10.1016/j.jebo.2012.03.008
- Hagenaars, J. A., & McCutcheon, A. L.(Eds.). (2002). *Applied latent class analysis*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi.org/10.1017/CBO9780511499531
- Heller, D., Watson, D., & Ilies, R. (2006). The dynamic process of life satisfaction. *Journal of Personality*, 74(5), 1421-1450. doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00415.x
- Krause, N. (2006). Social relationships in late life. In R. H. Binstock, & L. K. George(Eds.), *Handbook of aging and the social sciences*(6th ed., pp. 181-200). Burlington, MA: Academic Press. doi.org/10.1016/B978-012088388-2/50014-6
- Leung, A. S., Cheung, Y. H., & Liu, X. (2011). The relations between life domain satisfaction and subjective well-being. *Journal of Managerial Psychology*, 26(2), 155-169. doi.org/10.1108/02683941111102182
- Lo, Y., Mendell, N. R., & Rubin, D. B. (2001). Testing the number of components in a normal mixture. *Biometrika*, 88(3), 767-778. doi.org/10.1093/biomet/88.3.767
- Nylund, K. L., Asparouhov, T., & Muthén, B. O. (2007). Deciding on the number of classes in latent class analysis and growth mixture modeling: A Monte Carlo simulation study. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 14(4), 535-569. doi.org/10.1080/10705510701575396
- Nylund-Gibson, K., Garber, A. C., Carter, D. B., Chan, M., Arch, D. A., Simon, O., ... & Lawrie, S. I. (2023). Ten frequently asked questions about latent transition analysis. *Psychological Methods*, 28(2), 284-300. doi.org/10.1037/met0000486
- Nylund-Gibson, K., Grimm, R., Quirk, M., & Furlong, M. (2014). A latent transition mixture model using the three-step specification. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 21(3), 439-454. doi.org/10.1080/10705511.2014.915375
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2023a). *Health at a glance 2023: OECD Indicators*. Paris, France: OECD Publishing. doi.org/10.1787/19991312
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2023b). *Pensions at a glance 2023: OECD and G20 Indicators*. Paris, France: OECD Publishing. doi.org/10.1787/19991363
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2024). *Elderly population (indicator)*. <https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm>
- Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. *Psychological Assessment*, 5(2), 164-172. doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164
- Pavot, W., & Diener, E. (2008). The satisfaction with life scale and the emerging construct of life satisfaction. *The Journal of Positive Psychology*, 3(2), 137-152. doi.org/10.1080/17439760701756946
- Peel, D., & McLachlan, G. J. (2000). Robust mixture modelling using the t distribution. *Statistics and Computing*, 10, 339-348. doi.org/10.1023/A:1008981510081
- Rojas, M. (2006). Life satisfaction and satisfaction in domains of life: Is it a simple relationship? *Journal of Happiness*

- Studies*, 7, 467-497. doi.org/10.1007/s10902-006-9009-2
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. *The Gerontologist*, 37(4), 433-440. doi.org/10.1093/geront/37.4.433
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (2015). Successful aging 2.0: Conceptual expansions for the 21st century. *Journals of Gerontology: Series B*, 70(4), 593-596. doi.org/10.1093/geronb/gbv025
- Schimmack, U. (2008). *The structure of subjective well-being*. In M. Eid & R. J. Larsen(Eds.), *The science of subjective well-being*(pp. 97-123). New York: Guilford Press.
- Schimmack, U., & Oishi, S. (2005). The influence of chronically and temporarily accessible information on life satisfaction judgments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 89(3), 395-406. doi.org/10.1037/0022-3514.89.3.395
- Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461-464.
- Sclove, S. L. (1987). Application of model-selection criteria to some problems in multivariate analysis. *Psychometrika*, 52(3), 333-343. doi.org/10.1007/BF02294360
- Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. *Social Indicators Research*, 5, 475-492. doi.org/10.1007/BF00352944
- Takashima, R., Onishi, R., Saeki, K., & Hirano, M. (2020). Perception of COVID-19 restrictions on daily life among Japanese older adults: A qualitative focus group study. *Healthcare*, 8(4), 450. doi.org/10.3390/healthcare8040450
- The Whoqol Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. *Psychological Medicine*, 28(3), 551-558. doi.org/10.1017/S0033291798006667
- UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). (2022). *World Population Prospects 2022: Summary of results* (UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3). <https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022>
- Van Praag, B. M., Frijters, P., & Ferrer-i-Carbonell, A. (2003). The anatomy of subjective well-being. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 51(1), 29-49. doi.org/10.1016/S0167-2681(02)00140-3
- Vermunt, J. K. (2010). Latent class modeling with covariates: Two improved three-step approaches. *Political Analysis*, 18(4), 450-469. doi.org/10.1093/pan/mpq025
- Wettstein, M., Nowossadeck, S., & Vogel, C. (2022). Well-being trajectories of middle-aged and older adults and the corona pandemic: No “COVID-19 effect” on life satisfaction, but increase in depressive symptoms. *Psychology and Aging*, 37(2), 175-189. doi.org/10.1037/pag0000664
- WHO (World Health Organization). (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Wilmoth, J. R., Bas, D., Mukherjee, S., & Hanif, N. (2023). *World social report 2023: Leaving no one behind in an ageing world*. UN. <https://desapublications.un.org/publications/world-social-report-2023-leaving-no-one-behind-ageing-world>
- World Bank. (2021). *World Bank support to aging countries: An independent evaluation*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / World Bank. doi.org/10.1596/IEG159042